AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

GINECOLOGÍA

Oncología Ginecológica

16 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Endocrinología Ginecológica, Ciclo Menstrual & SUA

★★★ 20.1. Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea 3
★☆☆ 20.2. Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo 5
★★★ 20.3. Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo 6
★★☆ 20.4. Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis 7

02 Endometriosis, Piso Pélvico, Infertilidad & Anticoncepción

★★☆ 20.5. Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado 8
★☆☆ 20.6. Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia 10
★☆☆ 20.7. Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida 11
★★☆ 20.8. Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia GES 12

03 Infecciones Ginecológicas, Patología Vulvar & Climaterio

★★★ 20.9. Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis 14
★☆☆ 20.10. Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso 16
★☆☆ 20.11. Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos 17
★★★ 20.12. Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos 18

04 Oncología Ginecológica & Patología Mamaria

★★★ 20.13. Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía GES 19
★★★ 20.14. Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna GES 21
★★★ 20.15. Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores 23
★★☆ 20.16. Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico 24

Números que tienes que saber 25
Fármacos de primera línea 27
GES de la especialidad 27
Plan de repaso de 7 días 29
Índice por prioridad ★ 30

BLOQUE 01 · ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA, CICLO MENSTRUAL & SUA

20.1 Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

★★★ PRIORIDAD ALTA
22 preguntas reales 2013–2025

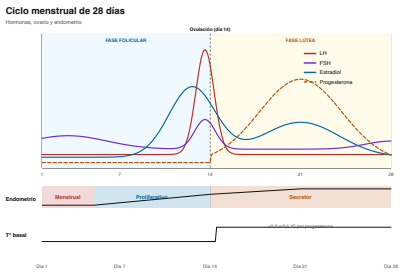
Máxima rentabilidad · Descartar embarazo como 1.ª causa, Test de Progesterona y algoritmo de amenorrea primaria

3.01.1.012
1.03.1.010 **Amenorrea** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Hiperprolactinemia · FSH, estradiol y prolactina · Pubertad (adolescencia) · Pubertad normal

LO QUE TE PREGUNTAN

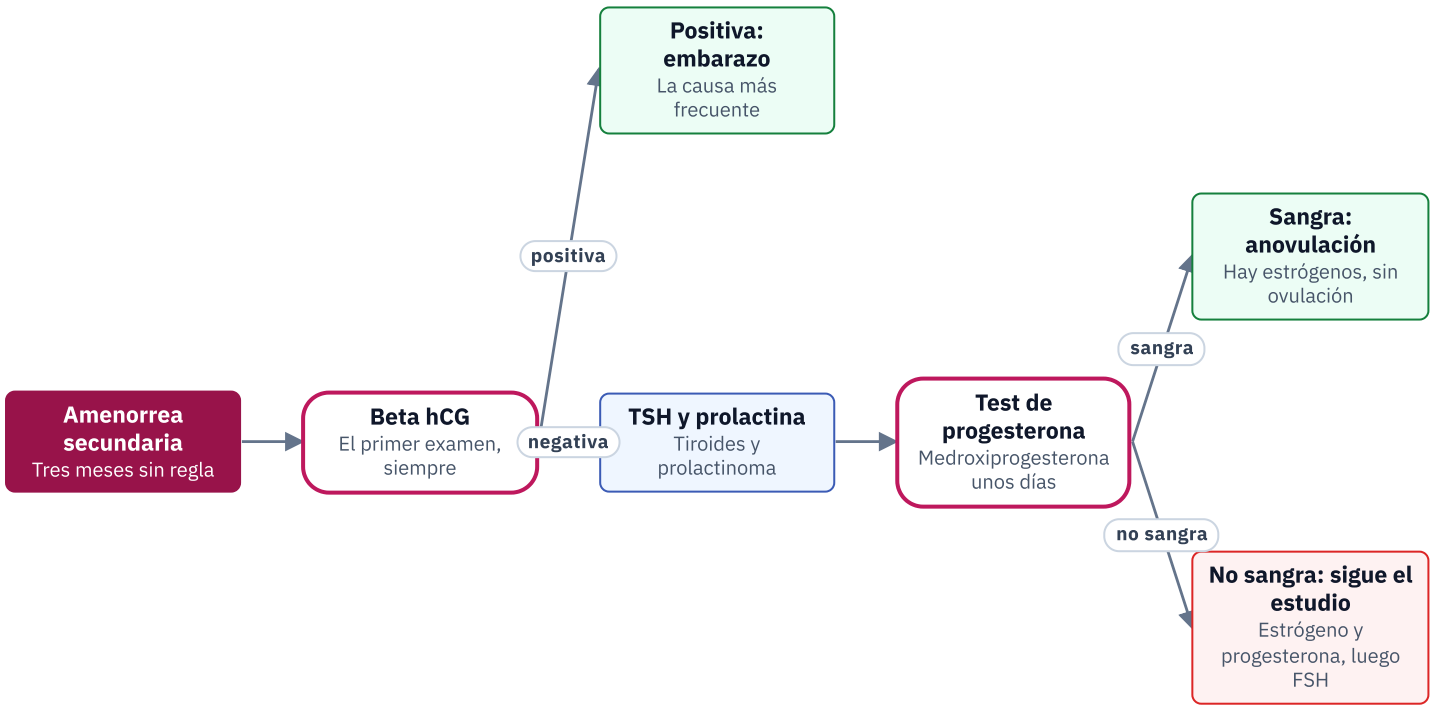
- **Fase folicular**: La FSH recluta el folículo dominante que produce Estradiol.
- **Pico de LH**: Gatillado por feedback positivo de estradiol > 200 pg/mL por **48h**; induce la ovulación a las **36 horas**.
- **Primer paso ante amenorrea secundaria**: SIEMPRE solicitar β-hCG para descartar EMBARAZO.
- **Test de progesterona positivo (sangra)**: Indica anovulación con estrógenos presentes (clásico de SOP).
- **Test de estrógeno + progestágeno negativo (no sangra)**: Causa anatómica en tracto de salida (Sd. de Asherman).
- **FSH marcadamente elevada en amenorrea**: Falla ovárica primaria (Insuficiencia ovárica precoz o Sd. Turner).
- **FSH baja en amenorrea**: Causa central hipotalámica funcional (estrés, anorexia, pérdida de peso) o hipofisaria.



CICLO DE VEINTIOCHO DÍAS
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · AMENORREA SECUNDARIA: EL ALGORITMO COMPLETO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **3–7** (págs. 8–9) · solucionario págs. 21–22.

Clase 20.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA, CICLO MENSTRUAL & SUA

20.1 Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 20.1 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE AMENORREA PRIMARIA

SÍNDROME	CARIOTIPO	FENOTIPO	MAMAS / VELLO	ÚTERO / VAGINA	GONADOTROFINAS (FSH/LH)
Rokitansky-Küster (Agenesia)	46, XX	Femenino normal	Mamas normales / Vello normal	AUSENTE (fondo ciego)	NORMALES (Ovarios funcionan)
Morris (Insensibilidad Andrógenos)	46, XY	Femenino alto	Mamas desarrolladas / SIN VELLO	AUSENTE (fondo ciego)	LH y Testosterona elevadas
Turner (Disgenesia gonadal)	45, X0	Talla baja, cuello alado	Mamas infantiles / Vello escaso	PRESENTE (pequeño)	ELEVADAS (Falla ovárica)
Kallmann (Hipogonadotropo)	46, XX o XY	Femenino o masculino	Infantilismo sexual	PRESENTE	MUY BAJAS (+ Anosmia)
Himen Imperforado	46, XX	Femenino normal	Normales	PRESENTE (Criptomenorrea)	NORMALES

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Amenorrea de cinco meses, embarazo descartado	TSH, prolactina y test de progesterona	Pedir cariotipo o ecografía de entrada
Test de progesterona positivo	Anovulación con estrógenos presentes	Confundirlo con falla ovárica
Test de estrógeno y progesterona negativo, con legrado previo	Sospechar Asherman y confirmar con histeroscopía	Repetir hormonas en vez de mirar la cavidad

REGLA DE ORO **Estradiol alto gatilla el pico de LH** — Ese pico produce la ovulación

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El ciclo menstrual femenino es regulado por la secreción pulsátil de GnRH hipotalámica, que induce la liberación de FSH y LH por la adenohipófisis para orquestar la foliculogénesis ovárica y la preparación endometrial. La amenorrea es uno de los motivos de consulta más frecuentes en ginecología y una pregunta clásica garantizada en el examen EUNACOM. El alumno debe dominar con absoluta precisión dos algoritmos indispensables: el estudio sistemático de la amenorrea secundaria (donde el primer paso obligatorio es SIEMPRE descartar embarazo con β-hCG, seguido del test de progesterona) y la diferenciación diagnóstica de las amenorreas primarias basada en la presencia o ausencia de caracteres sexuales secundarios y útero.

TABLA 20.1.B · ABORDAJE FARMACOLÓGICO ESCALONADO EN TRASTORNOS DEL CICLO Y AMENORREA

CAUSA SUBYACENTE	FÁRMACO / INTERVENCIÓN	MECANISMO Y DOSIS	META TERAPÉUTICA PRINCIPAL
Anovulación por SOP	Medroxiprogesterona o Progesterona micronizada	10 mg/d o 200 mg/d por 10-12 días al mes (o ACOs)	Prevenir hiperplasia y adenocarcinoma de endometrio por estímulo estrogénico no balanceado.
Hiperprolactinemia / Prolactinoma	Cabergolina (o Bromocriptina)	Agonista dopaminérgico D2: 0.5 mg 1 a 2 veces por semana	Normalizar prolactina, inducir regresión tumoral y restablecer fertilidad.
Amenorrea Hipotalámica Funcional	Manejo nutricional + Apoyo psicológico	Aumento ponderal, reducción del gasto energético, IMC > 19	Reactivar la secreción pulsátil fisiológica de GnRH en hipotálamo.
Síndrome de Asherman	Lisis histeroscópica de sinequias + Sonda Foley	Resección de bridas intrauterinas guiada + estrógenos a altas dosis	Restaurar la arquitectura y permeabilidad de la cavidad endometrial.

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **3–7** (págs. 8–9) · solucionario págs. 21–22.

Clase 20.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA, CICLO MENSTRUAL & SUA

20.2 Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
6 preguntas reales 2013–2025

3.01.3.015 Síndrome de ovario poliquístico — Conocimiento general

También: Oligoanovulación crónica · Hirsutismo

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Criterios de Rotterdam (se requieren 2 de 3)**: Oligo/anovulación + Hiperandrogenismo + Ecografía ovárica característica.
- **Criterio ecográfico actual**: **≥ 20 folículos** de **2-9 mm** en al menos un ovario o volumen ovárico > **10 mL**.
- **Descarte obligatorio de hiperplasia suprarrenal no clásica**: Medir 17-OH Progesterona matinal.
- **Fisiopatología central**: Hiperinsulinemia suprime la SHBG hepática, aumentando la testosterona libre.
- **Riesgo oncológico principal del SOP no tratado**: Hiperplasia y Cáncer de Endometrio por estrógenos sin oposición.

ALGORITMO · OVARIO POLIQUÍSTICO: DE LA SOSPECHA AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

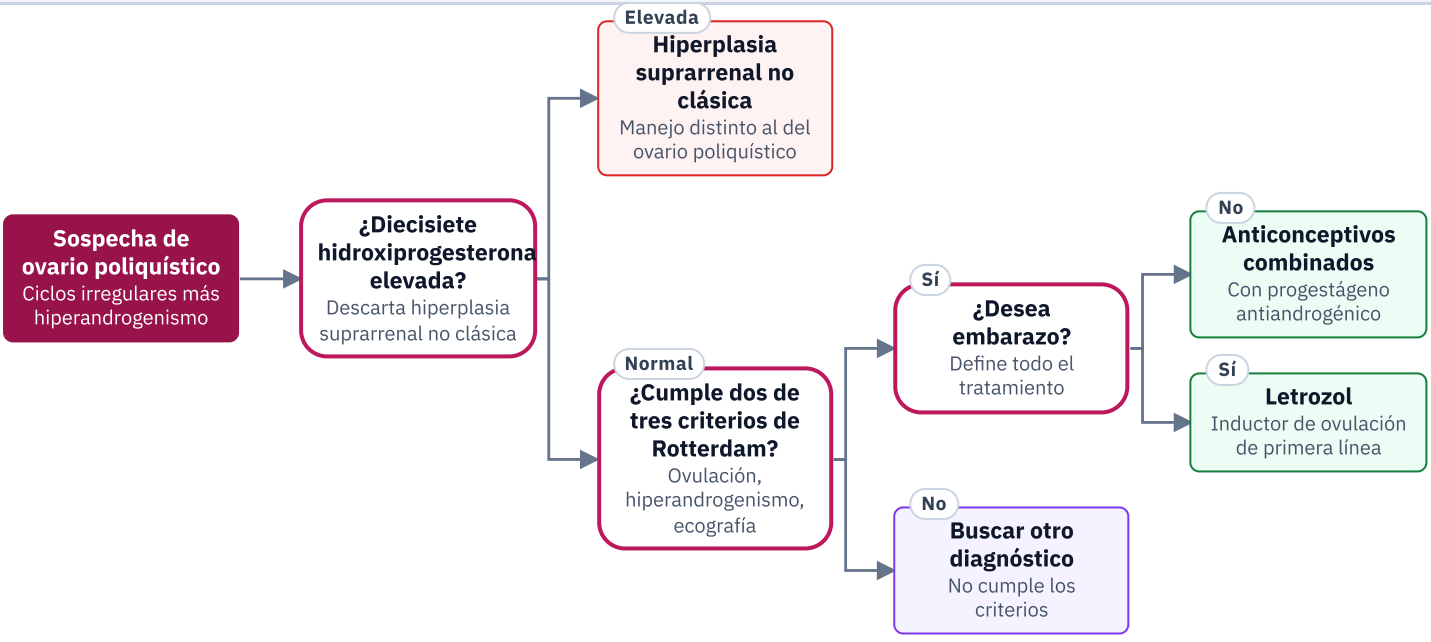


TABLA 20.2 · CRITERIOS DE ROTTERDAM PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO

CRITERIO DIAGNÓSTICO	DEFINICIÓN OPERATIVA EUNACOM	MÉTODO DE EVALUACIÓN
1. Disfunción Ovulatoria	Oligomenorrea (ciclos > 35 días) o Amenorrea (ausencia > 3 meses)	Anamnesis ginecológica y calendario menstrual
2. Hiperandrogenismo	Hirsutismo clínico, acné severo, alopecia o testosterona elevada	Score de Ferriman-Gallwey ≥ 8 / Testosterona libre
3. Ovario Poliquístico	≥ 20 folículos (2-9 mm) por ovario o volumen ovárico > 10 mL	Ecografía transvaginal ginecológica (fase folicular)
Exclusión Obligatoria	Descartar hiperplasia suprarrenal no clásica, hipotiroidismo, hiperprolactinemia	17-OH Progesterona, TSH, Prolactina séricas

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Hirsutismo y ciclos irregulares en adolescente	Diecisiete hidroxiprogesterona antes de cerrar el diagnóstico	Diagnosticar ovario poliquístico de entrada
No desea embarazo	Anticonceptivos con progestágeno antiandrogénico	Dar inductores de ovulación
Desea embarazo	Letrozol como primera línea	Empezar con anticonceptivos combinados

REGLA DE ORO **Rotterdam: dos de tres criterios** — Ovulación, hiperandrogenismo, ecografía

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **8–10, 37** (págs. 9, 13) · solucionario págs. 22–23, 27.

Clase 20.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA, CICLO MENSTRUAL & SUA

20.3 Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo

★★★ PRIORIDAD ALTA
33 preguntas reales 2013–2025

3.01.1.018 **Hemorragia genital anormal** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

También: Hemorragia genital aguda (metrorragia disfuncional-cervicorragia por Cáncer C.U.) · Patología benigna del endometrio (hiperplasia, pólipos...) · Alteraciones menstruales

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Clasificación FIGO PALM-COEIN**: PALM = Estructurales (Pólipo, Adenomiosis, Leiomioma, Malignidad).
- **COEIN** = No Estructurales (Coagulopatía, Ovulatoria, Endometrial, Iatrogénica, No clasificada).
- **Causa más común de sangrado abundante severo en adolescentes**: Coagulopatía (Enfermedad de von Willebrand).
- **Biopsia endometrial ambulatoria (Pipelle)**: OBLIGATORIA en toda mujer **≥ 45 años** con SUA.
- Toda paciente postmenopáusica con sangrado uterino DEBE recibir biopsia de endometrio (corte ecográfico > **4 mm**).
- Mujeres < **45 años** requieren biopsia si tienen factores de riesgo: Obesidad, SOP, tamoxifeno, Lynch.



CLASIFICACIÓN PALM-COEIN
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · SANGRADO UTERINO ANORMAL: ¿CUÁNDO BIOPSIAR?

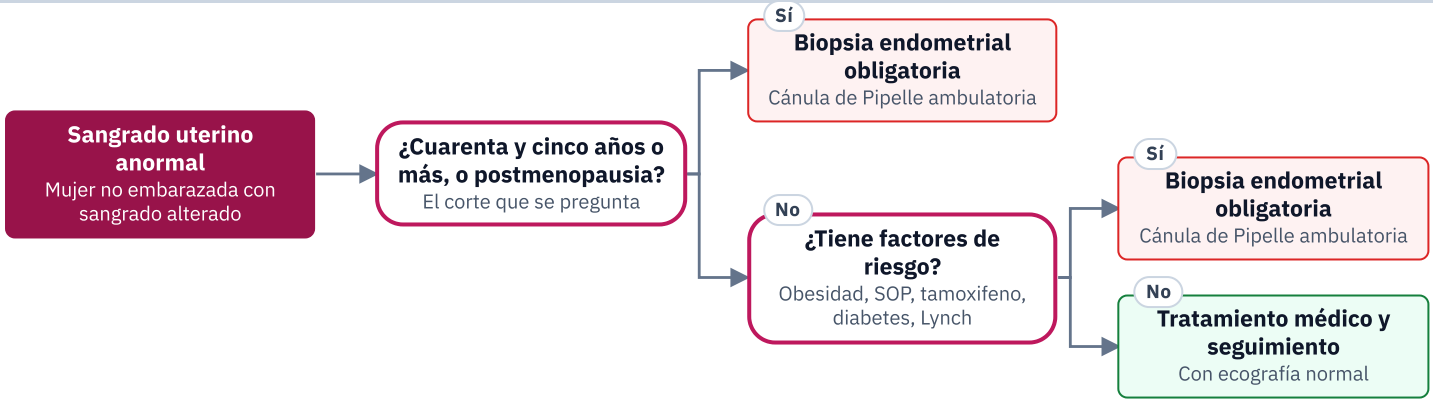


TABLA 20.3 · CLASIFICACIÓN FIGO PALM-COEIN DE LAS CAUSAS DE SANGRADO UTERINO ANORMAL

CATEGORÍA	ETIOLOGÍA	NATURALEZA	DIAGNÓSTICO DE ELECCIÓN	TRATAMIENTO HABITUAL
P	Pólipos Endometriales	Estructural	Ecografía TV / Histerosonografía	Polipectomía por histeroscopía
A	Adenomiosis	Estructural	RMN pélvica / Eco TV Doppler	DIU-LNG / AINEs / Histerectomía
L	Leiomiomas (Miomas)	Estructural	Ecografía TV (mapeo FIGO)	Miomectomía / DIU-LNG / Embolización
M	Malignidad e Hiperplasia	Estructural	Biopsia Pipelle / Histeroscopía	Oncológico: Cirugía etapificadora
C	Coagulopatías	No estructural	Estudio hemostasia (vWF, plaquetas)	Ácido tranexámico / Desmopresina
O	Disfunción Ovulatoria	No estructural	Historia clínica (anovulación, SOP)	Progestágenos / ACOs combinados
E	Causas Endometriales	No estructural	Diagnóstico de exclusión	DIU-LNG / Ácido tranexámico / AINEs
I	Causas Iatrogénicas	No estructural	Fármacos (anticoagulantes, DIU-Cu)	Retiro o cambio de método
N	No Clasificadas	No estructural	Malformaciones arteriovenosas	Angiografía / Embolización

REGLA DE ORO **PALM: estructural** — Pólipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **11–16** (págs. 9–10) · solucionario págs. 23–24.

Clase 20.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA, CICLO MENSTRUAL & SUA

20.4 Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
9 preguntas reales 2013–2025

3.01.1.021 Mioma uterino — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Completo

También: Tacto ginecológico para masas u alteraciones obstructivas

LO QUE TE PREGUNTAN

- Los miomas son los tumores benignos sólidos más comunes del aparato genital femenino.
- **Miomas submucosos (FIGO 0, 1 y 2)**: Son los que más sangran y causan infertilidad.
- **Miomas subserosos (FIGO 6 y 7)**: Provocan síntomas compresivos (vejiga/recto) sin aumentar el sangrado.
- **Miomas asintomáticos**: Conducta expectante y control anual (NO se operan de rutina).
- **Degeneración roja**: Infarto aséptico doloroso típico del embarazo; manejo médico analgésico.

ALGORITMO · MIOMATOSIS UTERINA: SÍNTOMAS Y FERTILIDAD

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

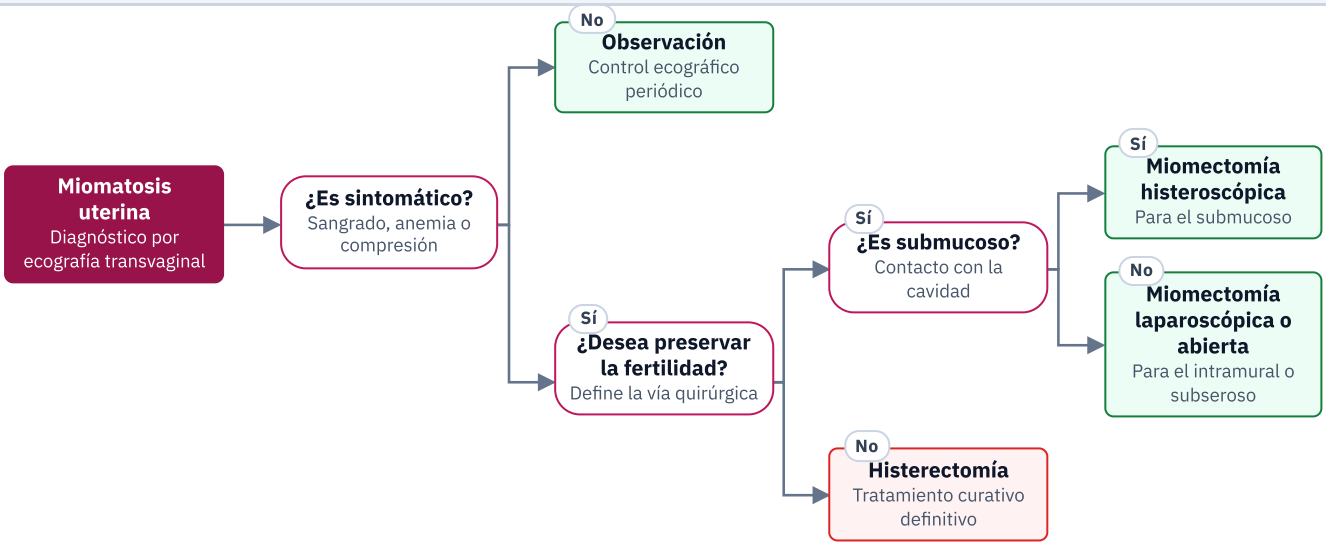


TABLA 20.4 · CLASIFICACIÓN FIGO DE LOS LEIOMIOMAS UTERINOS SEGÚN SU LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN FIGO	LOCALIZACIÓN ANATÓMICA	MANIFESTACIÓN CLÍNICA PRINCIPAL	ABORDAJE QUIRÚRGICO PREFERENTE
FIGO 0	Submucoso pediculado 100% intracavitario	Hipermenorrea severa, sangrado intermenstrual	Miomectomía Histeroscópica
FIGO 1	Submucoso con extensión intramural < 50%	Hipermenorrea, anemia ferropénica	Miomectomía Histeroscópica
FIGO 2	Submucoso con extensión intramural ≥ 50%	Hipermenorrea, dismenorrea	Miomectomía Histeroscópica / Laparoscópica
FIGO 3	100% Intramural en contacto con endometrio	Hipermenorrea moderada	Miomectomía Laparoscópica / Histerectomía
FIGO 4	100% Intramural puro sin contacto seroso/mucoso	Asintomático o hipermenorrea	Manejo médico / Miomectomía
FIGO 5	Subseroso con extensión intramural ≥ 50%	Síntomas compresivos leves	Laparoscopía si sintomático
FIGO 6	Subseroso con extensión intramural < 50%	Compresión vesical / rectal	Miomectomía Laparoscópica

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Mioma asintomático, hallazgo incidental	Observación y control ecográfico	Operar solo porque se encontró
Sangrado con endometrio grueso en postmenopausia	Biopsia de endometrio	Atribuir el sangrado al mioma

REGLA DE ORO **Submucoso: sangra** — Subseroso: comprime

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **17–18** (pág. 10) · solucionario pág. 24.

Clase 20.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN

20.5 Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
10 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad · Tríada de dismenorrea progresiva + dispareunia + infertilidad; ecografía en vidrio esmerilado y Dienogest

3.01.1.015 Endometriosis — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Dolor pelviano y dismenorrea

LO QUE TE PREGUNTAN

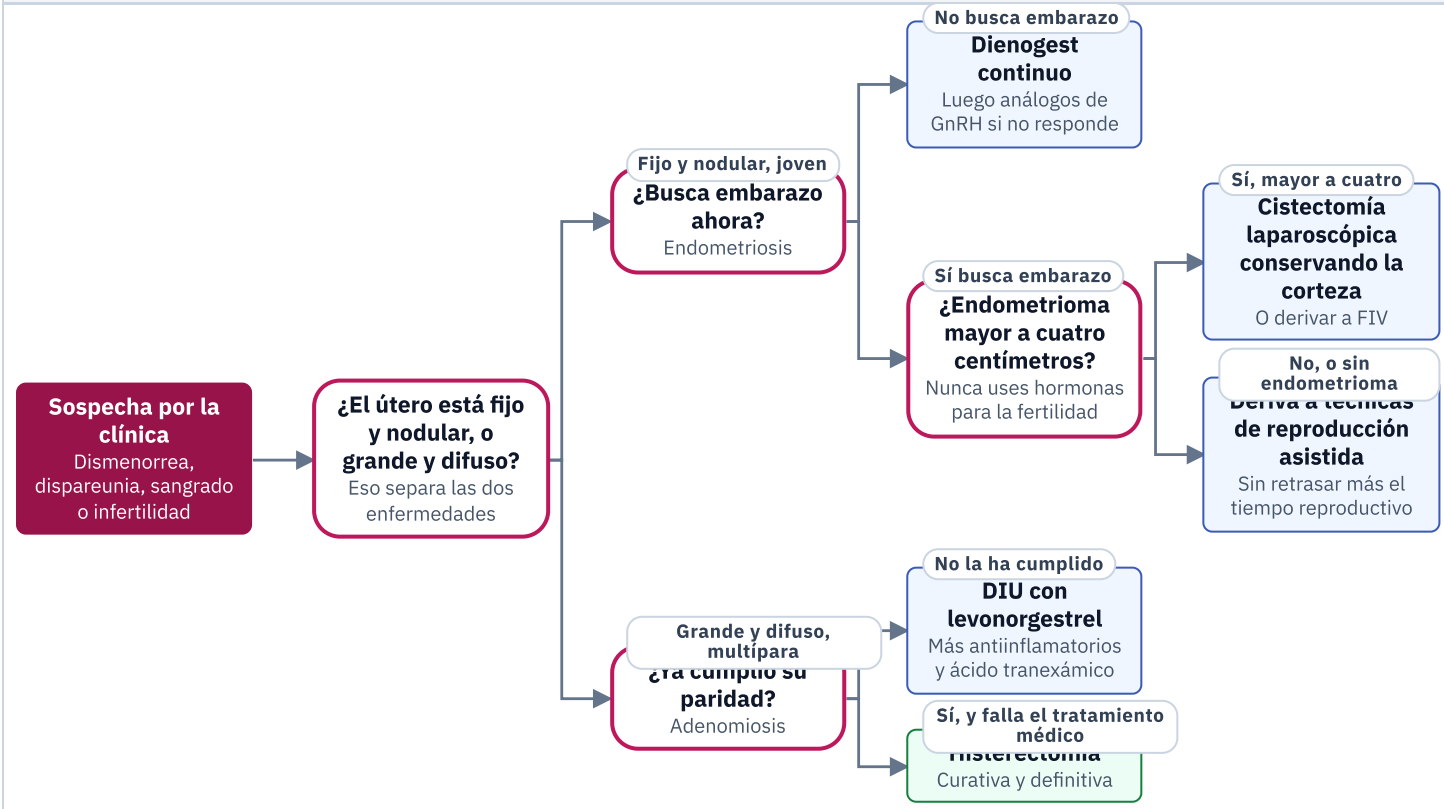
- **Fisiopatología**: Menstruación retrógrada (Sampson), inflamación crónica estrógeno-dependiente.
- **Tríada cardinal clásica**: Dismenorrea secundaria progresiva + Dispareunia profunda + Infertilidad.
- **Localización anatómica más frecuente**: Ovarios (Endometrioma o 'quiste de chocolate').
- **Ecografía transvaginal del endometrioma**: Quiste homogéneo con ecos finos en 'vidrio esmerilado' sin papilas.
- **Estándar de oro imagenológico en endometriosis profunda**: Resonancia Magnética (RMN) de pelvis.
- **Estándar de oro diagnóstico definitivo**: Laparoscopía quirúrgica con confirmación histopatológica.
- **Tratamiento médico de elección para dolor pélvico**: Dienogest **2 mg**/día oral continuo o ACOs continuos.



ENDOMETRIOMA
Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 74

ALGORITMO · ENDOMETRIOSIS Y ADENOMIOSIS: QUÉ DECIDE LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **1, 21–29** (págs. 8, 11–12) · solucionario págs. 21, 25–26.

Clase 20.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN

20.5 Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 20.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO Y TERAPÉUTICO ENTRE ENDOMETRIOSIS Y ADENOMIOSIS

PARÁMETRO	ENDOMETRIOSIS PÉLVICA	ADENOMIOSIS UTERINA
Definición Histológica	Glándulas y estroma endometrial FUERA del útero (ovarios, peritoneo)	Glándulas y estroma endometrial EN EL ESPESOR del miometrio
Edad Típica	Mujeres jóvenes en edad reproductiva (20 a 35 años)	Mujeres multíparas de 35 a 50 años
Síntomas Cardinales	Dismenorrea progresiva + Dispareunia profunda + Infertilidad	Hipermenorrea abundante + Dismenorrea secundaria tardía
Examen Físico	Útero en retroversión fija, ligamentos uterosacros nodulares dolorosos	Útero aumentado de tamaño difuso, blando, globuloso y doloroso
Ecografía Transvaginal	Endometrioma ovárico en 'vidrio esmerilado', adherencias	Miometrio heterogéneo con sombras en 'rayos solares' y asimetría
Manejo Médico	Dienogest 2 mg continuo, ACOs continuos, DIU-LNG	DIU-Levonorgestrel (Mirena), Ácido Tranexámico, AINEs
Tratamiento Quirúrgico	Cistectomía ovárica laparoscópica / escisión de implantes	Histerectomía total (curativo en paridad satisfecha)

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Dolor típico, sin deseo de embarazo	Dienogest continuo	Pedir laparoscopía de entrada
Quiste en vidrio esmerilado, sin papilas	Es un endometrioma benigno	Pensar en cáncer y operar de urgencia
Útero grande, blando y difuso	Sospechar adenomiosis	Confundirlo con miomatosis

REGLA DE ORO **Fuera del útero: endometriosis** — Joven, dolor y nódulos fijos

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La Endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial funcional (glándulas y estroma) fuera de la cavidad uterina. Afecta al 10-15% de las mujeres en edad reproductiva y hasta al 40-50% de las mujeres con dolor pélvico crónico o infertilidad. Su patogenia clásica se atribuye a la teoría de la menstruación retrógrada de Sampson, con adhesión, invasión y proliferación estrógeno-dependiente de células endometriales en el peritoneo pélvico y ovarios. La tríada clínica clásica de dismenorrea progresiva severa que no cede con AINEs habituales, dispareunia profunda e infertilidad es de altísima rentabilidad para el EUNACOM. El pilar médico actual descansa en los progestágenos continuos (Dienogest) y el abordaje quirúrgico laparoscópico reservado para dolor refractario o endometriomas voluminosos.

TABLA 20.5.B · ESQUEMAS TERAPÉUTICOS FARMACOLÓGICOS OFICIALES EN ENDOMETRIOSIS (MINSAL / ESHRE)

FÁRMACO / MODALIDAD	DOSIS Y POSOLOGÍA	MECANISMO DE ACCIÓN	EFECTOS SECUNDARIOS PRINCIPALES
Dienogest (1.ª Línea de Elección)	2 mg vía oral una vez al día de forma continua (sin descansos)	Progestágeno sintético: anovulación, decidualización y atrofia de focos	Spotting irregular en primeros meses, cefalea, cambios de humor.
ACOs Combinados Continuos	1 comprimido diario continuo sin descanso de 7 días	Inhibición del eje y amenorrea inducida farmacológicamente	Riesgo trombótico según criterios de elegibilidad OMS.
DIU-Levonorgestrel	Dispositivo intrauterino (20 mcg/día)	Atrofia endometrial profunda local y reducción de dismenorrea	Sangrado intermenstrual inicial, excelente tolerancia a largo plazo.
Análogos GnRH (Leuprolide)	3.75 mg IM mensual o 11.25 mg trimestral por máximo 6 meses	Hipoestrogenismo severo ('menopausia médica')	Sofocos, sequedad vaginal, pérdida de densidad mineral ósea (osteopenia).

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **1, 21–29** (págs. 8, 11–12) · solucionario págs. 21, 25–26.

Clase 20.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN

20.6 Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
4 preguntas reales 2013–2025

3.01.1.026 Prolapso genital — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Incontinencia urinaria

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Incontinencia de esfuerzo**: Pérdida sincrónica con tos, risa o ejercicio por hipermovilidad uretral.
- **Tratamiento quirúrgico de elección en IUE**: Cintas o cabestrillos mediouretrales libres de tensión (TOT / TVT).
- **Incontinencia de urgencia / Vejiga hiperactiva**: Escape tras deseo imperioso súbito por hiperactividad del detrusor.
- ¡LA CIRUGÍA ESTÁ FORMALMENTE CONTRAINDICADA en la incontinencia de urgencia pura!
- **Tratamiento médico de IUU**: Reeducación vesical + Antimuscarínicos (Solifenacina, Oxibutinina) o Mirabegrón.



SISTEMA POP-Q
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · INCONTINENCIA URINARIA: QUÉ DECIDE EL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 20.6 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO Y DE URGENCIA

CARACTERÍSTICA	INCONTINENCIA DE ESFUERZO (IUE)	INCONTINENCIA DE URGENCIA (IUU)
Mecanismo Desencadenante	Aumento brusco de presión intraabdominal (tos, risa, esfuerzo)	Deseo miccional repentino e incontrolable ('no alcanza a llegar al baño')
Volumen de Pérdida	Escaso a moderado (en chorro o gotas sincrónicas con el esfuerzo)	Moderado a abundante (vaciado vesical completo súbito)
Fisiopatología	Falla anatómica del soporte uretral (hipermovilidad uretral)	Contracciones involuntarias del músculo detrusor (hiperactividad)
Síntomas Asociados	Habitualmente no tiene polaquiuria ni nicturia	Polaquiuria diurna (> 8 veces) y nicturia (> 2 veces) frecuentes
Prueba de Esfuerzo al Examen	POSITIVA sincrónica inmediata con la tos	NEGATIVA (salvo contracción inducida tardía)
Tratamiento Médico	Poco eficaz (solo fisioterapia de Kegel en casos leves)	MUY EFICAZ: Reeducación vesical + Anticolinérgicos / Mirabegrón
Tratamiento Quirúrgico	ESTÁNDAR DE ORO: Cintas mediouretrales TOT / TVT	¡CONTRAINDICADO! (Empeora la hiperactividad del detrusor)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CARACTERÍSTICA	INCONTINENCIA DE ESFUERZO	INCONTINENCIA DE URGENCIA
Cirugía	Estándar de oro: TOT o TVT	Formalmente contraindicada

REGLA DE ORO **¿Con esfuerzo o con urgencia?** — Esa pregunta ordena todo

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **30–33** (pág. 12) · solucionario págs. 26–27.

Clase 20.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN

20.7 Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida

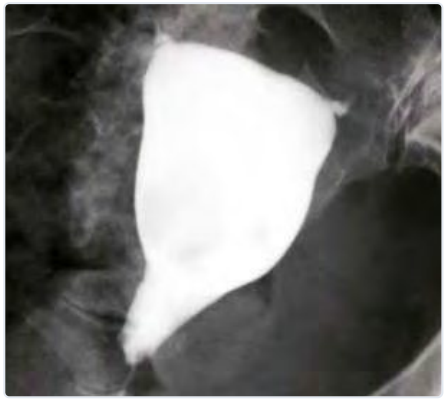
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
7 preguntas reales 2013–2025

3.01.1.020 Infertilidad conyugal — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Histerosalpingografía · Infertilidad masculina · LH, testosterona

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Infertilidad**: **12 meses** de búsqueda infructuosa en < **35 años**; **6 meses** si la mujer tiene **≥ 35 años**.
- **Distribución etiológica**: **35%** masculina, **30%** tubárica, **20%** ovulatoria, **15%** idiopática o mixta.
- **Espermiograma**: Requiere **3-5 días** de abstinencia. Concentración normal **≥ 15 mill/mL**, motilidad progresiva **≥ 30-32%**.
- Si un espermiograma está alterado, debe repetirse obligatoriamente una segunda muestra en **1 a 3 meses**.
- **Histerosalpingografía (HSG)**: Prueba de Cotte positiva confirma permeabilidad tubárica.



HISTEROSALPINGOGRAFÍA
Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 50

ALGORITMO · INFERTILIDAD CONYUGAL: LOS CUATRO PILARES Y LA TÉCNICA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

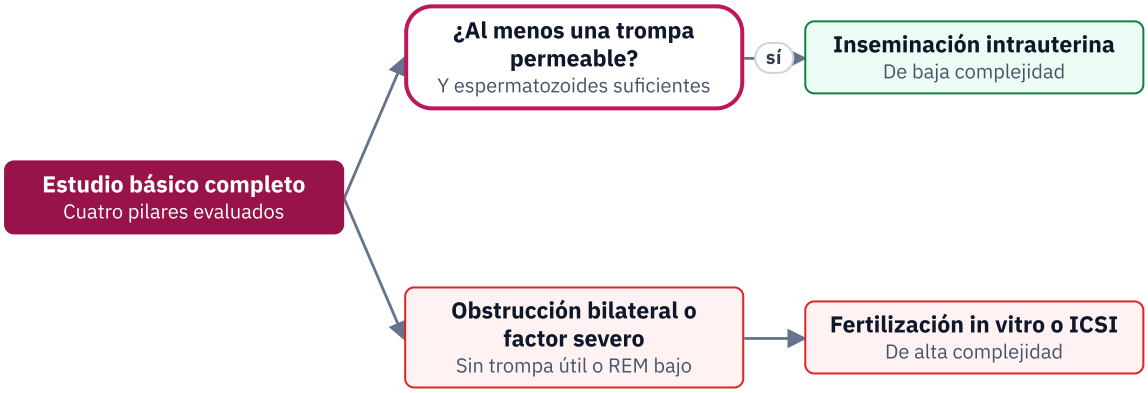


TABLA 20.7 · CRITERIOS DE ELECCIÓN ENTRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA (BAJA VS ALTA COMPLEJIDAD)

PARÁMETRO CLÍNICO	BAJA COMPLEJIDAD (INSEMINACIÓN INTRAUTERINA)	ALTA COMPLEJIDAD (FIV / ICSI)
Estado de las Trompas de Falopio	OBLIGATORIO: Al menos una trompa permeable (Cotte +)	Permeabilidad IRRELEVANTE (indicada en obstrucción bilateral)
Calidad Seminal (REM Post-capacitación)	REM ≥ 3 a 5 millones de espermatozoides móviles	Apta para factor severo (REM < 1-3 mill, azoospermia)
Lugar de la Fecundación	In vivo (dentro de la trompa de la mujer)	In vitro (en el laboratorio de embriología)
Complejidad y Cirugía	Ambulatoria en consulta, sin anestesia ni punción	Requiere punción ovárica bajo sedación en pabellón
Costo y Tasa de Éxito por Ciclo	Bajo costo · Éxito 12 - 18% por ciclo	Alto costo · Éxito 35 - 50% por ciclo
Indicaciones Clásicas EUNACOM	SOP que no ovula con letrozol, factor masculino leve, ISCA	Obstrucción tubárica bilateral, factor masculino grave, > 38 años

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Primera consulta de la pareja	Espermiograma para él	Empezar solo con exámenes de ella
Espermiograma alterado	Repetirlo en uno a tres meses	Diagnosticar infertilidad masculina de inmediato
Obstrucción tubárica bilateral	Fertilización in vitro	Intentar inseminación intrauterina

REGLA DE ORO **Primero, el espermiograma** — Antes que cualquier examen de ella

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **34–36** (págs. 12–13) · solucionario pág. 27.

Clase 20.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN

20.8 Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
12 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad · Criterios OMS Categoría 4 (Contraindicaciones absolutas de estrógenos), PAE Levonorgestrel 1.5 mg y DIU

3.01.3.008 Anticoncepción — Conocimiento general

También: Métodos naturales para la regulación de la fecundidad

LO QUE TE PREGUNTAN

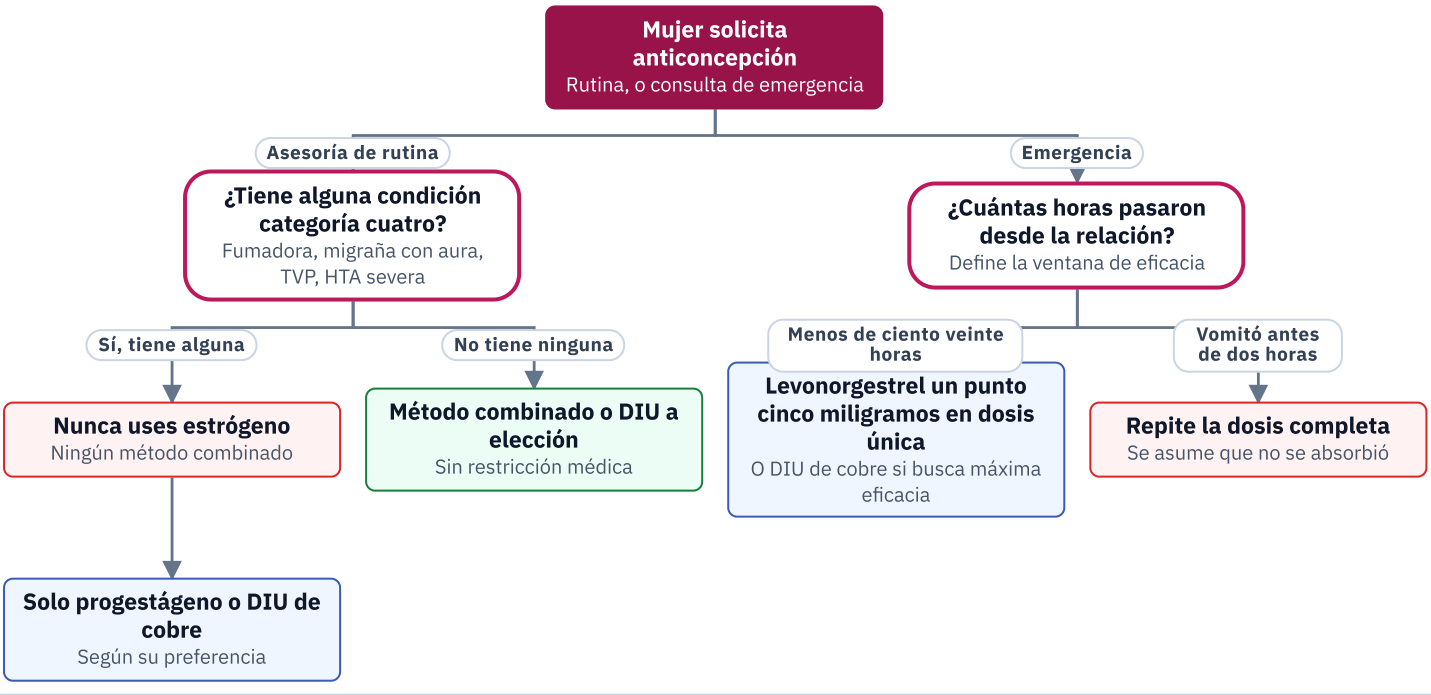
- **Criterios OMS**: Categoría 1 = Sin restricción; Categoría 4 = Contraindicación absoluta inaceptable.
- **Fumadora ≥ 35 años con ≥ 15 cig/d**: CATEGORÍA 4 para métodos combinados con estrógenos.
- **Migraña CON AURA a cualquier edad**: CATEGORÍA 4 para métodos combinados (riesgo de ACV isquémico).
- **Antecedente de TVP/TEP o trombofilia**: CATEGORÍA 4 para métodos combinados.
- **Métodos de solo progestágeno (Implante, Minipíldora, DIU-LNG)**: NO aumentan el riesgo de trombosis.
- Son seguros en fumadoras > **35 años**, migraña con aura y durante la lactancia materna.
- **Implante subdérmico de Etonogestrel**: Método reversible con menor tasa de falla de toda la medicina (Pearl 0.05).



IMPLANTE SUBDÉRMICO
Wikimedia Commons «Implanon 04.jpg», CC BY-SA 4.0, Vera de Kok

ALGORITMO · ANTICONCEPCIÓN: ELEGIBILIDAD Y EMERGENCIA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **41–44** (pág. 14) · solucionario págs. 28–29.

Clase 20.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN

20.8 Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 20.8 · CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD OMS: MÉTODOS COMBINADOS VS SOLO PROGESTÁGENO

CONDICIÓN MÉDICA DE LA PACIENTE	MÉTODOS COMBINADOS (ESTRÓGENO + PG)	MÉTODOS SOLO PROGESTÁGENO	DIU DE COBRE
Fumadora ≥ 35 años que fuma ≥ 15 cig/día	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)
Migraña CON AURA a cualquier edad	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)	CATEGORÍA 1 o 2 (Seguro)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)
Antecedente Personal de TVP o TEP	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)	CATEGORÍA 2 (Aceptable)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)
Hipertensión Arterial Severa (≥ 160/100)	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)	CATEGORÍA 1 o 2 (Seguro)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)
Lactancia Materna (< 6 semanas postparto)	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)	CATEGORÍA 2 (Seguro)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)
Cáncer de Mama Actual	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)
Infección Pélvica Activa (EIP / Cervicitis)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)	CATEGORÍA 1 (Sin restricción)	CATEGORÍA 4 (PROHIBIDO)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CONDICIÓN MÉDICA	MÉTODOS COMBINADOS	SOLO PROGESTÁGENO	DIU DE COBRE
Trombosis venosa previa	Categoría cuatro, prohibido	Aceptable	Sin restricción

REGLA DE ORO **Fumadora, migraña con aura, TVP** — O hipertensión severa

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La prescripción informada y segura de métodos anticonceptivos es una de las competencias más evaluadas en el EUNACOM. La Organización Mundial de la Salud (OMS) categoriza la seguridad de los métodos en cuatro niveles: Categoría 1 (sin restricción), Categoría 2 (ventajas superan riesgos), Categoría 3 (riesgos superan ventajas) y Categoría 4 (RIESGO INACEPTABLE / CONTRAINDICACIÓN FORMAL ABSOLUTA). El médico general debe reconocer de forma instantánea las condiciones Categoría 4 que prohíben el uso de estrógenos (migraña con aura, fumadora ≥ 35 años, antecedente de trombosis venosa profunda o hipertensión arterial severa), debiendo optar por métodos de solo progestágeno o de barrera/cobre. Asimismo, se debe dominar el uso de la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE) con Levonorgestrel 1.5 mg.

TABLA 20.8.B · PROTOCOLOS FARMACOLÓGICOS EN ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA (PAE)

MÉTODO	FÁRMACO Y DOSIS	VENTANA DE TIEMPO EFICAZ	CONSIDERACIONES Y MANEJO DE VÓMITOS
Levonorgestrel (1.ª Línea en APS)	1.5 mg vía oral en dosis única (o 2 comp de 0.75 mg)	Primeras 72 horas (útil hasta 120h)	Si vomita en < 2 horas post-toma: REPETIR LA DOSIS. No es abortivo.
Acetato de Ulipristal	30 mg vía oral en dosis única	Hasta 120 horas (5 días postcoito)	Modulador del receptor de progesterona. Mayor eficacia que LNG en sobrepeso.
DIU de Cobre de Rescate	Inserción de T de Cobre intrauterina	Hasta 120 horas (5 días postcoito)	Método de rescate más eficaz (> 99%). Requiere disponibilidad y colocación por profesional capacitado.

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **41–44** (pág. 14) · solucionario págs. 28–29.

Clase 20.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES GINECOLÓGICAS, PATOLOGÍA VULVAR & CLIMATERIO

20.9 Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad · Criterios de Amsel en vaginosis bacteriana, tratamiento en pareja en tricomoniasis y leucorrea en leche cortada

3.01.1.019 Infecciones genitourinarias — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Enfermedades de transmisión sexual · Flujo vaginal (pH) · Examen ginecológico, especuloscopia y tacto bimanual · Candidiasis urogenital · Leucorrea y vulvovaginitis

LO QUE TE PREGUNTAN

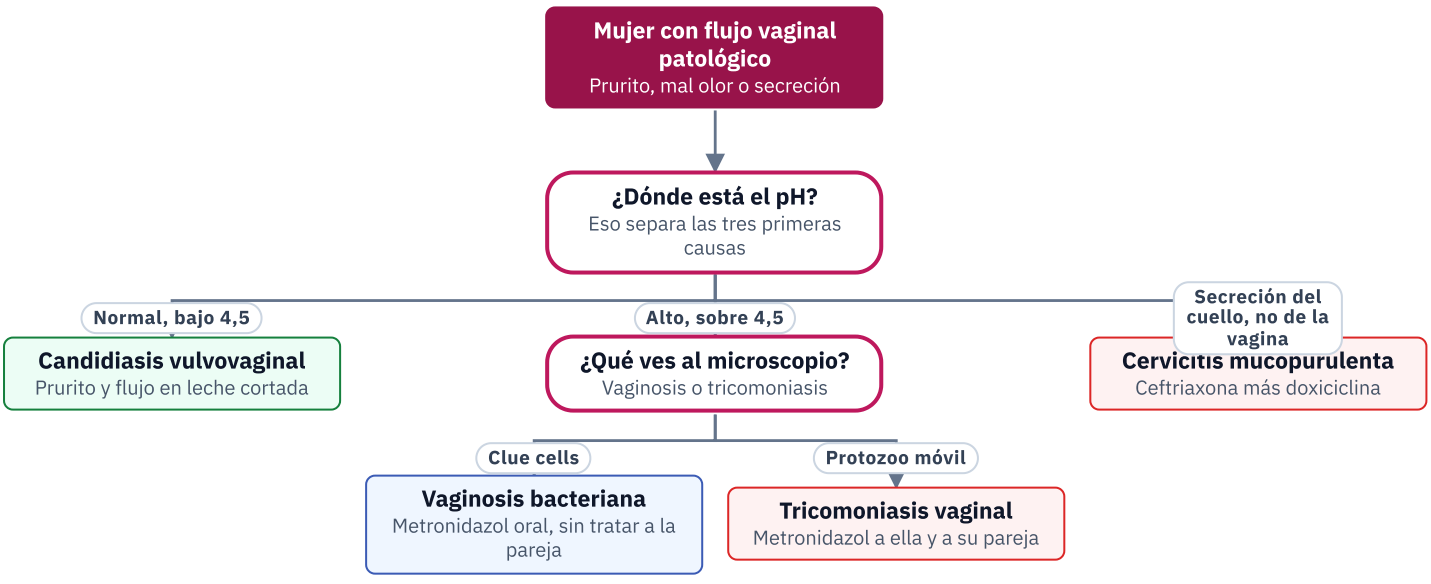
- **Vaginosis bacteriana**: Criterios de Amsel (flujo blanco-grisáceo, pH > 4.5, aminas +, clue cells > **20%**).
- **Tratamiento de Vaginosis**: Metronidazol oral **500 mg** c/**12h** x **7 días**. NO requiere tratar a la pareja.
- **Candidiasis**: Prurito intenso + leucorrea en 'leche cortada' adherente + pH ÁCIDO NORMAL (< 4.5).
- **Tratamiento de Candidiasis**: Fluconazol **150 mg** oral dosis única o Clotrimazol óvulos (único en embarazo).
- **Tricomoniasis**: ITS con flujo espumoso amarillo-verdoso, cuello en fresa y protozoo flagelado móvil.
- **Tratamiento de Tricomoniasis**: Metronidazol **2g** oral dosis única A LA PACIENTE Y A SU PAREJA OBLIGATORIA.
- **Cervicitis mucopurulenta**: Secreción cervical purulenta. Tratamiento dual: Ceftriaxona **500 mg** IM + Doxiciclina **7 días**.



VAGINOSIS BACTERIANA
Kumar and Clark's Clinical Medicine, p. 1586

ALGORITMO · VULVOVAGINITIS Y CERVICITIS: QUÉ DECIDE EL DIAGNÓSTICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **19, 45–54** (págs. 11, 14–15) · solucionario págs. 24, 29–30.

Clase 20.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES GINECOLÓGICAS, PATOLOGÍA VULVAR & CLIMATERIO

20.9 Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 20.9 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL MICROBIOLÓGICO Y CLÍNICO DE LAS VULVOVAGINITIS

CARACTERÍSTICA	VAGINOSIS BACTERIANA	CANDIDIASIS VULVOVAGINAL	TRICOMONIASIS VAGINAL
Etiología	Disbiosis (Gardnerella + anaerobios)	Candida albicans (hongo levaduriforme)	Trichomonas vaginalis (protozoo flagelado)
Aspecto del Flujo	Homogéneo, blanco-grisáceo, fluido	Blanco, espeso, grumoso ('leche cortada')	Abundante, amarillo-verdoso, espumoso
Síntoma Dominante	Mal olor penetrante ('olor a pescado')	Prurito vulvar intenso y ardor	Flujo abundante, prurito y dispareunia
Eritema / Inflamación	Mínimo o ausente (no inflamatoria)	Eritema vulvovaginal severo + fisuras	Eritema vaginal + 'cuello en fresa'
pH Vaginal	ELEVADO (> 4.5, habitualmente 5.0)	NORMAL / ÁCIDO (< 4.5)	MUY ELEVADO (> 5.0 a 6.0)
Test de Aminas (KOH)	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	Habitualmente POSITIVO (+)
Microscopía en Fresco	Clue cells (> 20%), ausencia lactobacilos	Esporas y pseudohifas filamentosas	Parásito flagelado móvil ovalado
Tratamiento Pareja	NO indicado de rutina	NO indicado (no es ITS)	OBLIGATORIO SIMULTÁNEO (Es ITS)
Tratamiento de Elección	Metronidazol oral 500 mg c/12h x 7d	Clotrimazol óvulos o Fluconazol 150 mg	Metronidazol 2g oral dosis única (ambos)

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Flujo gris, sin dolor, pH alto	Metronidazol solo a la paciente	Tratar también a la pareja
Prurito y leche cortada, pH normal	Fluconazol en dosis única	Confundirlo con vaginosis por el pH
Flujo espumoso, cuello en fresa	Metronidazol a la paciente y a su pareja	Tratar solo a la paciente

REGLA DE ORO **pH normal: candidiasis** — Es el único que no lo altera

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

Las infecciones del tracto genital inferior (vulvovaginitis y cervicitis) representan el motivo de consulta ginecológica más prevalente en la atención médica ambulatoria. El médico general debe saber diferenciar con absoluta certeza las tres entidades clásicas de vulvovaginitis mediante la clínica, el pH vaginal, el test de aminas (KOH al 10%) y el frotis al microscopio: 1) Vaginosis Bacteriana (disbiosis con pérdida de lactobacilos y proliferación de Gardnerella/anaerobios; diagnosticada por Criterios de Amsel); 2) Candidiasis Vulvovaginal (infección fúngica con prurito severo y leucorrea en leche cortada con pH ácido normal < 4.5); y 3) Tricomoniasis (infección de transmisión sexual por protozoo flagelado, con flujo espumoso verdoso, cuello en fresa y donde es ESTRICTAMENTE OBLIGATORIO tratar a la pareja sexual simultáneamente).

TABLA 20.9.B · PROTOCOLOS FARMACOLÓGICOS OFICIALES DE TRATAMIENTO EN ITS Y VAGINITIS (MINSAL)

CUADRO CLÍNICO	FÁRMACO DE ELECCIÓN	POSOLOGÍA OFICIAL	CONSIDERACIONES ESPECIALES
Vaginosis Bacteriana	Metronidazol oral	500 mg cada 12 horas por 7 días	Evitar alcohol durante y hasta 48h post-tratamiento (Efecto Antabuse).
Candidiasis No Complicada	Fluconazol oral (o Clotrimazol vaginal)	150 mg oral dosis única (o óvulos 100 mg/noche x 6 días)	En embarazadas: ¡SOLO TRATAMIENTO TÓPICO (Clotrimazol)! No usar fluconazol oral.
Tricomoniasis Vaginal	Metronidazol oral	2 g por vía oral en dosis única (o 500 mg c/12h x 7d)	TRATAR A LA PAREJA OBLIGATORIAMENTE con el mismo esquema y abstinencia.
Cervicitis Mucopurulenta	Ceftriaxona IM + Doxiciclina oral	Ceftriaxona 500 mg IM única + Doxiciclina 100 mg c/12h x 7d	Cubrir siempre Gonococo + Chlamydia. Notificación obligatoria ENO.

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **19, 45–54** (págs. 11, 14–15) · solucionario págs. 24, 29–30.

Clase 20.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES GINECOLÓGICAS, PATOLOGÍA VULVAR & CLIMATERIO

20.10 Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
7 preguntas reales 2013–2025

3.01.2.002 Absceso glándula de Bartolino — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Drenaje abceso glándula Bartolino

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Localización de glándulas de Bartolino**: Tercio posterior de labios mayores (posiciones de las 4 y **8 horas**).
- **Quiste de Bartolino**: Retención de moco aséptica e indolora. Observar si es asintomático.
- **Absceso de Bartolino**: Infección bacteriana con dolor agudo intenso, masa fluctuante y eritema.
- **Tratamiento curativo de elección en Absceso de Bartolino**: Drenaje quirúrgico con MARSUPIALIZACIÓN (o Catéter de Word).
- ¡La simple punción con aguja o incisión aislada tiene más del **80%** de recidiva y está desaconsejada!
- **Liquen escleroso vulvar**: Prurito crónico intratable + placas nacaradas en 'figura de ocho' o 'cerradura'.



QUISTE DE BARTOLINO
The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 269

ALGORITMO · PATOLOGÍA VULVAR: QUÉ DECIDE LA CONDUCTA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

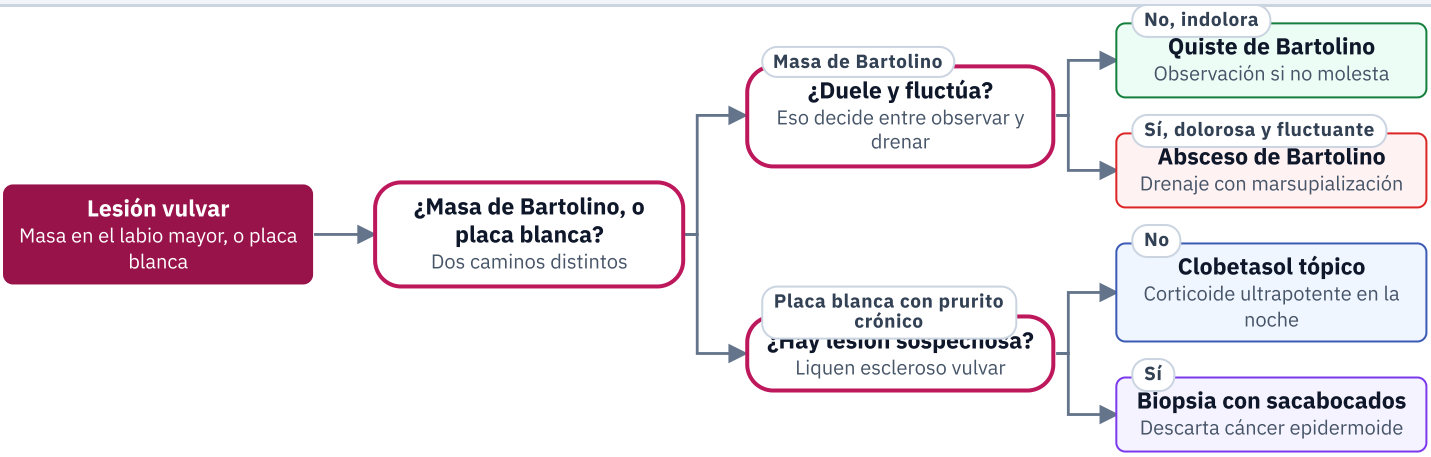


TABLA 20.10 · DIAGNÓSTICO Y MANEJO COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS VULVARES

ENTIDAD	FISIOPATOLOGÍA	MANIFESTACIONES CLÍNICAS	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Quiste de Bartolino	Oclusión mecánica aséptica del conducto	Masa redondeada indolora a las 4 u 8 horas del reloj	Observación (si asintomático) o Marsupialización
Absceso de Bartolino	Sobreinfección bacteriana aguda purulenta	Tumefacción fluctuante, eritematosa y exquisitamente dolorosa	Drenaje quirúrgico con MARSUPIALIZACIÓN (o Catéter de Word)
Liquen Escleroso	Dermatosis inflamatoria autoinmune atrófica	Prurito crónico severo + placas blancas nacaradas en 'cerradura'	Corticoides ultrapotentes tópicos: Clobetasol 0.05%
Cáncer de Vulva	Carcinoma epidermoide (asociado a VPH o liquen)	Úlcera vulvar crónica que no cicatriza o masa nodular sangrante	Biopsia punch obligatoria -> Vulvectomía radical + ganglio centinela

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Masa vulvar indolora, sin eritema	Observación si es asintomática	Drenar un quiste que no molesta
Masa fluctuante, eritematosa, muy dolorosa	Drenaje con marsupialización	Punción simple con aguja
Prurito crónico, placas en cerradura	Clobetasol tópico	Tratarlo como candidiasis

REGLA DE ORO **Sin dolor: observar** — No se drena un quiste sano

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **38–40** (pág. 13) · solucionario pág. 28.

Clase 20.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES GINECOLÓGICAS, PATOLOGÍA VULVAR & CLIMATERIO

20.11 Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
5 preguntas reales 2013–2025

3.01.1.025 Proceso inflamatorio pelviano — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Pelviperitonitis

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Etiología de EIP**: Polimicrobiana mixta iniciada por Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae + anaerobios.
- **Criterios mayores de Hager (los 3 obligatorios)**: Dolor hipogástrico + Dolor a movilización cervical + Dolor anexial.
- **Secuelas mayores a largo plazo**: Dolor pélvico crónico, infertilidad tubárica y embarazo ectópico.
- **Inserción de DIU**: Solo aumenta el riesgo de EIP durante las primeras **3 a 6 semanas** post-inserción.
- **Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis**: Perihepatitis con adherencias en 'cuerdas de violín' entre hígado y diafragma.



ABSCESO TUBOOVÁRICO (ECO)
Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 102

ALGORITMO · ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA: DIAGNÓSTICO Y GRAVEDAD

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 20.11 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE HAGER Y MANEJO DE LA EIP SEGÚN ESTADIO DE MONIF

ESTADIO MONIF	DEFINICIÓN CLÍNICA Y HALLAZGOS	LUGAR DE TRATAMIENTO	ESQUEMA ANTIBIÓTICO INDICADO
Estadio I	Salpingitis aguda sin pelviperitonitis ni masas	Ambulatorio (con control en 72h)	Ceftriaxona 500 mg IM + Doxiciclina 100 mg c/12h x 14d + Metronidazol x 14d
Estadio II	Salpingitis aguda con pelviperitonitis localizada	Ambulatorio estricto o Hospitalizado	Ceftriaxona IM/EV + Doxiciclina oral + Metronidazol oral x 14 días
Estadio III	Absceso Tubo-Ovárico (ATO) íntegro palpable / eco	HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA	Ceftriaxona 2g EV + Doxiciclina + Metronidazol (o Clindamicina + Gentamicina EV)
Estadio IV	Absceso Tubo-Ovárico ROTO con shock séptico	HOSPITALIZACIÓN UCI / Pabellón	LAPAROTOMÍA EXPLORADORA DE URGENCIA + Antibióticos EV triples de rescate

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Los tres criterios mayores de Hager	Ya puedes diagnosticar	Pedir imágenes antes de tratar
Dolor en hipocondrio derecho con EIP	Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis	Pensar solo en colecistitis
DIU instalado hace un año	No es factor de riesgo de EIP	Retirarlo por precaución

REGLA DE ORO **Hipogastrio, cuello y anexos** — Los tres, siempre

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **2, 55–59** (págs. 8, 15–16) · solucionario págs. 21, 31.

Clase 20.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES GINECOLÓGICAS, PATOLOGÍA VULVAR & CLIMATERIO

20.12 Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

3.01.1.027 Síndrome climatérico y menopausia — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Manejo de la salud de la mujer climatérica · Síndrome climatérico · Sexualidad en personas mayores

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Diagnóstico de menopausia**: Clínico (**12 meses** continuos de amenorrea en > **45 años**). No requiere exámenes de rutina.
- **Ventana de oportunidad de TRH**: Iniciar en < **60 años** o < **10 años** postmenopausia para máximo beneficio y mínimo riesgo.
- **Mujer CON útero**: OBLIGATORIO asociar Progestágeno al Estrógeno para proteger contra Cáncer de Endometrio.
- **Mujer SIN útero (histerectomizada)**: Estrógenos SOLOS en monoterapia (¡NO agregar progestágeno!).
- **Atrofia urogenital aislada**: Estrógenos tópicos locales (Estriol vaginal) de mínima absorción sistémica.
- **Contraindicaciones absolutas de TRH**: Cáncer de mama, cáncer de endometrio, TVP/TEP, cardiopatía isquémica, SUA no filiado.

ALGORITMO · TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL: A QUIÉN, Y CÓMO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

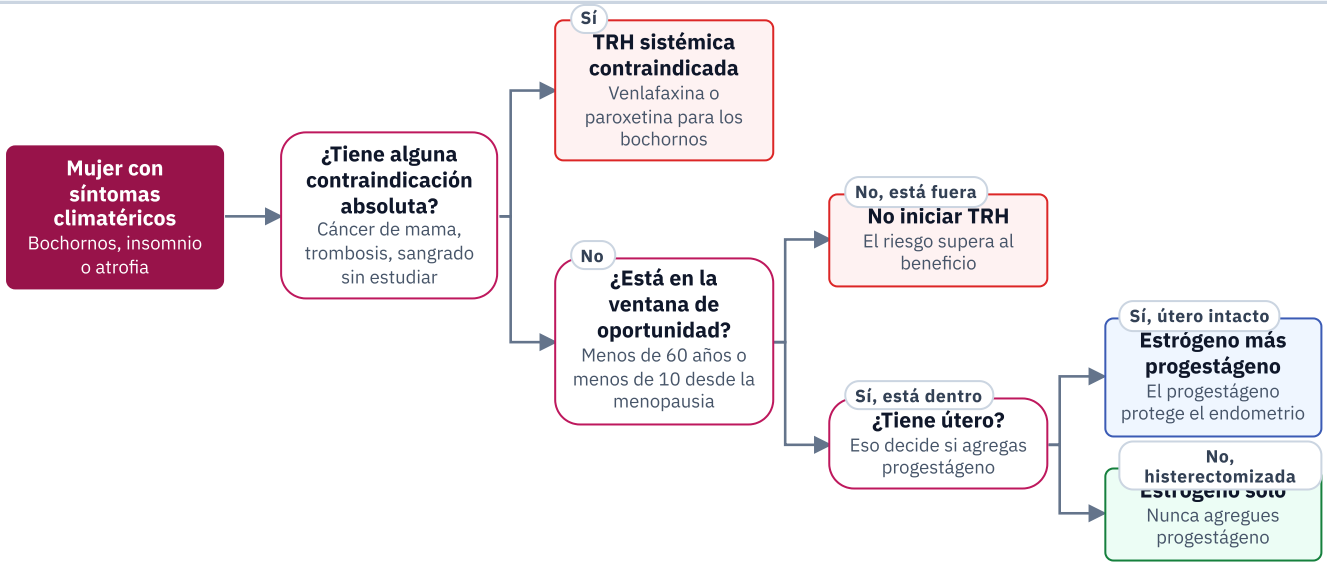


TABLA 20.12 · ESQUEMAS DE TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL SEGÚN ANATOMÍA UTERINA

SITUACIÓN ANATÓMICA	COMPOSICIÓN DE LA TRH	VÍA PREFERENTE	RAZÓN FISIOPATOLÓGICA
Mujer con Útero Intacto	Estrógenos + Progestágeno (Continuo o Cíclico)	Oral o Transdérmica (parche/gel)	El progestágeno es OBLIGATORIO para prevenir hiperplasia y cáncer de endometrio.
Mujer Histerectomizada	Estrógenos SOLOS (Monoterapia estrogénica)	Oral o Transdérmica	No hay endometrio que proteger; evita el riesgo mamario añadido del progestágeno.
Atrofia Vaginal Exclusiva	Estrógenos Tópicos Locales (Estriol / Promestrieno)	Crema u óvulos vaginales	Alivio directo urogenital sin efectos secundarios sistémicos ni necesidad de progestágeno.
Riesgo Trombótico Leve / HTA	Estrógenos Transdérmicos (Gel o Parche)	Vía Transdérmica estricta	Evita el primer paso hepático, no estimula factores de coagulación ni triglicéridos.

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Histerectomizada, con bochornos	Estrógeno solo	Agregar progestágeno igual
Cáncer de mama previo	TRH sistémica contraindicada	Darla porque los síntomas son severos
Mujer de 65 años, sin terapia previa	No iniciar TRH	Iniciarla porque tiene síntomas

REGLA DE ORO **Doce meses sin regla** — Sin exámenes de rutina

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **60–61** (pág. 16) · solucionario pág. 32.

Clase 20.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA & PATOLOGÍA MAMARIA

20.13 Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

★★★
PRIORIDAD ALTA
25 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad · Tamizaje PAP cada 3 años (25-64a), conducta ante PAP alterado (Colposcopía) y estadios precoces vs avanzados (≥IIB)

3.01.1.013 **Cáncer cervicouterino** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Enfermedad preinvasora del cuello uterino-Lesiones genitales intraepiteliales (NIE-HPV) · Screening ginecológico: Papanicolau, mamografía · Papanicolau · Taponaje vaginal · Toma de Papanicolau (incluye hacer el frotis)

LO QUE TE PREGUNTAN

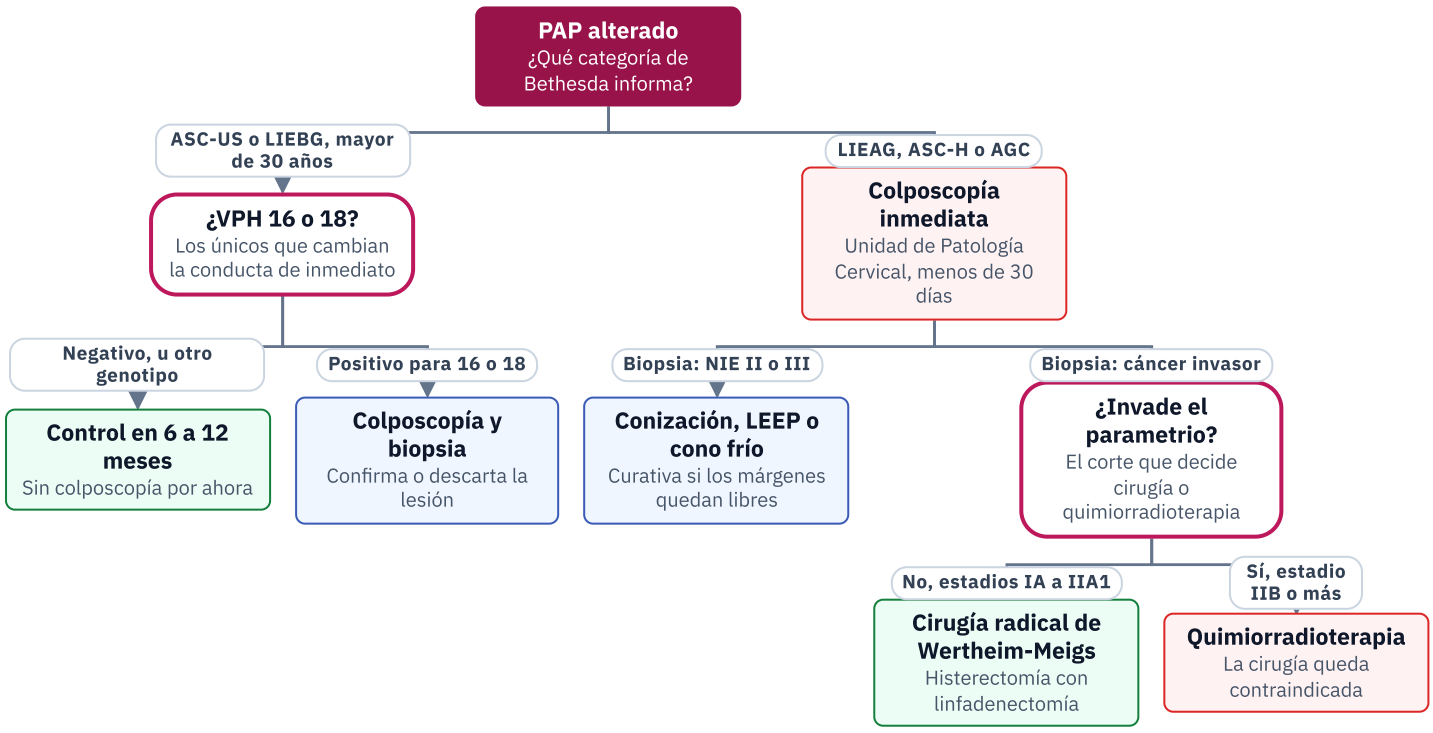
- **GES N° 3 Cáncer Cervicouterino**: Tamizaje universal con PAP cada **3 años** en mujeres de **25 a 64 años**.
- **Etiología**: Virus Papiloma Humano serotipos de alto riesgo oncogénico (VPH 16 en **60%** y VPH 18 en **15%**).
- **Oncoproteínas oncogénicas**: E6 degrada al gen supresor p53; E7 inactiva a la proteína pRb.
- **PAP con LIEAG (H-SIL) o NIE II-III**: DERIVACIÓN INMEDIATA A COLPOSCOPÍA Y BIOPSIA en UPC (Garantía GES < **30 días**).
- **Tratamiento de NIE II / NIE III**: Conización cervical (LEEP o Cono Frío) con márgenes libres.
- **Síntoma clínico más temprano del cáncer invasor**: Sangrado postcoital (sinusorragia) indoloro.
- **Estadios precoces sin invasión de parametrios (IA, IB1, IB2)**: Cirugía radical de Wertheim-Meigs.



LESIÓN DE BAJO GRADO
Williams Gynecology 4.ª ed., Fig. 29-12

ALGORITMO · DEL PAP ALTERADO A LA DECISIÓN FINAL

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **62–72** (págs. 16–18) · solucionario págs. 32–34.

Clase 20.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA & PATOLOGÍA MAMARIA

20.13 Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 20.13 · ETAPIFICACIÓN FIGO Y TRATAMIENTO DE ELECCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO

ESTADIO FIGO	EXTENSIÓN ANATÓMICA DEL TUMOR	TRATAMIENTO PRIMARIO DE ELECCIÓN	PRONÓSTICO (SG 5 AÑOS)
Estadio IA1	Microscópico: Invasión estromal < 3 mm sin invasión vascular	Conización cervical (si desea fertilidad) o Histerectomía total	> 98%
Estadio IB1 / IB2	Tumor invasor confinado a cérvix (< 4 cm de diámetro)	Histerectomía Radical + Linfadenectomía (Wertheim-Meigs)	85 - 90%
Estadio IIA1	Invasión vaginal superior < 4 cm sin parametrios	Cirugía Radical de Wertheim-Meigs o Quimiorradioterapia	75 - 80%
Estadio IIB	INVASIÓN DE PARAMETRIOS (sin llegar a pared pélvica)	QUIMIORRADIOTERAPIA (Cisplatino + Radioterapia + Braquiterapia)	60 - 65%
Estadio IIIB	Extensión a pared pélvica y/o Hidronefrosis renal	Quimioterapia con Cisplatino + Radioterapia pélvica	35 - 45%
Estadio IVA / IVB	Invasión de vejiga/recto o Metástasis a distancia	Tratamiento sistémico paliativo (Platino + Paclitaxel + Bevacizumab)	< 15%

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
ASC-US en mayor de 30 años	Test de VPH	Colposcopía de entrada
VPH+ (no 16 ni 18), PAP normal	Control en 6 a 12 meses	Colposcopía inmediata
LIEAG, ASC-H o AGC	Colposcopía en menos de 30 días	Repetir el PAP para confirmar

REGLA DE ORO **PAP cada 3 años** — De los 25 a los 64 años

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El Cáncer Cervicouterino (CCU) es la segunda neoplasia ginecológica más frecuente y una causa mayor de muerte prevenible en mujeres chilenas en edad fértil y perimenopáusica. Está cubierto integralmente por las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 3). El 99.7% de los casos se debe a la infección persistente por genotipos oncogénicos del Virus del Papiloma Humano (VPH), principalmente los tipos 16 y 18. El tamizaje universal en Chile se realiza con el Papanicolaou (PAP) cada 3 años entre los 25 y 64 años (y progresivamente con Test de VPH). El médico general debe dominar el algoritmo ante un PAP alterado (derivación obligatoria a Colposcopía y biopsia en la Unidad de Patología Cervical - UPC) y el corte crucial de tratamiento: la cirugía radical se reserva para estadios precoces confinados al cuello, mientras que ante invasión de parametrios (Estadio ≥ IIB) la cirugía está estrictamente contraindicada y el tratamiento curativo es la Quimiorradioterapia con Cisplatino.

TABLA 20.13.B · MODALIDADES TERAPÉUTICAS EN LESIONES CERVICALES PREINVASORAS E INVASORAS

PATOLOGÍA	PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN	OBJETIVO ONCOLÓGICO	CRITERIOS DE ÉXITO
NIE II / NIE III (LIEAG)	Conización con asa LEEP o Cono Frío	Extirpación de la zona de transformación y canal	Márgenes quirúrgicos endocervicales y ectocervicales libres de displasia.
CCU Estadio IB1 (< 2 cm)	Histerectomía Radical (Wertheim-Meigs)	Extirpación de útero, parametrios, tercio sup vaginal y ganglios	Ausencia de metástasis ganglionares y parametrios libres.
CCU Estadio IIB en adelante	Quimiorradioterapia concomitante	Cisplatino semanal (40 mg/m²) como radiosensibilizador + Braquiterapia	Respuesta tumoral completa y esterilización parametrial.
Recidiva Pélvica Central	Exenteración Pélvica	Resección en bloque de útero, vagina, vejiga y recto	Procedimiento de rescate en recurrencias centrales post-radioterapia.

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **62–72** (págs. 16–18) · solucionario págs. 32–34.

Clase 20.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA & PATOLOGÍA MAMARIA

20.14 Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

★★★ PRIORIDAD ALTA
32 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad · Clasificación BI-RADS (4 y 5 requieren Core Biopsy), tamizaje GES 50-69 años y subtipos moleculares

3.01.1.030
4.01.1.035
Cáncer de mama
Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Patología benigna de mama · Mamografía · Screening ginecológico: Papanicolau, mamografía · Ecotomografía mamaria · Patología mamaria benigna · Diagnóstico precoz del cáncer mamario

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Cáncer de mama**: Primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile (GES N° 4 desde los **15 años**).
- **Tamizaje GES**: Mamografía bilateral bienal (cada **2 años**) en mujeres de **50 a 69 años**.
- **BI-RADS 3**: Probablemente benigno (< **2%** riesgo); requiere seguimiento mamográfico en **6 meses**.
- **BI-RADS 4 y 5**: Sospechosos de malignidad; exigen BIOPSIA CON AGUJA GRUESA (Core Biopsy) obligatoria.
- La PAAF citológica NO sirve para diagnóstico inicial porque no distingue carcinoma in situ de invasor.
- **Cirugía conservadora (tumorectomía)**: EXIGE SIEMPRE RADIOTERAPIA COMPLEMENTARIA de la mama restante.
- **Biopsia de Ganglio Centinela**: De elección en axila clínicamente negativa para evitar vaciamiento y linfedema.



MASA ESPICULADA
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 53.2

ALGORITMO · BI-RADS: LEER EL INFORME Y DECIDIR

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **20, 74–78** (págs. 11, 18–19) · solucionario págs. 25, 34–35.

Clase 20.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA & PATOLOGÍA MAMARIA

20.14 Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 20.14 · SISTEMA DE CLASIFICACIÓN RADIOLÓGICA BI-RADS Y CONDUCTA CLÍNICA OBLIGATORIA

CATEGORÍA BI-RADS	SIGNIFICADO RADIOLÓGICO	RIESGO ESTIMADO DE MALIGNIDAD	CONDUCTA MÉDICA OBLIGATORIA
BI-RADS 0	Estudio Incompleto	No determinado	Solicitar proyecciones adicionales o Ecografía mamaria complementaria
BI-RADS 1	Negativa / Completamente Normal	0%	Mamografía de tamizaje rutinaria cada 2 años
BI-RADS 2	Hallazgos Benignos (quistes, fibroadenoma calcificado)	0%	Mamografía de tamizaje rutinaria cada 2 años
BI-RADS 3	Probablemente Benigno (nódulo sólido circunscrito)	< 2%	SEGUIMIENTO ESTRICTO: Control mamográfico a los 6 meses
BI-RADS 4	Sospechosa de Malignidad (4A, 4B, 4C)	2 a 95%	BIOPSIA OBLIGATORIA (Core Biopsy percutánea guiada)
BI-RADS 5	Altamente Sospechosa (nódulo espiculado + microcalcificaciones)	> 95%	BIOPSIA OBLIGATORIA (Core Biopsy) y derivación oncológica expedita
BI-RADS 6	Malignidad Comprobada por Biopsia previa	100%	Planificación terapéutica multidisciplinaria (cirugía/neoadyuvancia)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

HALLAZGO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Telorrea hemática uniporo	Ecografía y resección del conducto	Atribuirla a mastopatía fibroquística
Cirugía conservadora	Radioterapia siempre	Omitirla si el margen quedó libre
Receptores + y Ki-67 alto	Luminal B: quimioterapia y hormonoterapia	Tratarlo solo con hormonoterapia

REGLA DE ORO **Mamografía bienal** — De los 50 a los 69 años

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El Cáncer de Mama es la primera causa de muerte por neoplasia maligna en las mujeres en Chile y en el mundo occidental. Está priorizado en el sistema de salud chileno bajo la Garantía Explícita en Salud (GES N° 4) para personas de 15 años y más. El único método que ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de mama en ensayos clínicos es la Mamografía de Tamizaje, garantizada bienalmente entre los 50 y 69 años. El informe mamográfico utiliza el sistema internacional BI-RADS, donde las categorías 4 y 5 exigen obligatoriamente la realización de una Biopsia con aguja gruesa (Core Biopsy). El tratamiento moderno es multidisciplinario e individualizado según los subtipos moleculares (Luminal A, Luminal B, HER2 enriquecido y Triple Negativo).

TABLA 20.14.B · MODALIDADES TERAPÉUTICAS QUIRÚRGICAS Y ADYUVANTES EN CÁNCER DE MAMA

INTERVENCIÓN	INDICACIONES CLÍNICAS	PREMISAS OBLIGATORIAS EUNACOM	MORBILIDAD / SECUELAS PREVENIDAS
Cirugía Conservadora (Tumorectomía)	Tumores unifocales con bordes libres y mama adecuada	¡OBLIGATORIA RADIOTERAPIA POSTOPERATORIA a toda la mama restante!	Preservación estética e identidad corporal con idéntica sobrevida que mastectomía.
Biopsia Ganglio Centinela	Axila clínicamente negativa (cN0) al examen y eco	Inyección peritumoral de radioisótopo/tinte y extirpación del primer ganglio	Evita el vaciamiento axilar completo y reduce el linfedema de extremidad superior en > 90%.
Tamoxifeno (Hormonoterapia)	Tumores con receptores hormonales (+) en premenopáusicas	Modulador selectivo de receptores estrogénicos (SERM) por 5-10 años	Aumenta riesgo de hiperplasia/cáncer endometrial y TVP (requiere control ginecológico).
Inhibidores de Aromatasa (Anastrozol)	Tumores con receptores hormonales (+) en postmenopáusicas	Bloquean la síntesis periférica de estrógenos en tejido graso	Provocan artralgias y aceleran osteoporosis (requiere densitometría ósea y calcio/vit D).

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **20, 74–78** (págs. 11, 18–19) · solucionario págs. 25, 34–35.

Clase 20.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA & PATOLOGÍA MAMARIA

20.15 Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

★★★ PRIORIDAD ALTA
24 preguntas reales 2013–2025

3.01.1.024 Patología maligna del endometrio — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Tumores ováricos · Ecotomografía ginecológica · Conceptos generales de etapificación, radioterapia y quimioterapia

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Regla de oro**: Toda metrorragia en la postmenopausia es Cáncer de Endometrio hasta demostrar lo contrario.
- **Grosor endometrial normal en postmenopausia**: Menor a **4 a 5 mm** (si usa TRH hasta **8 mm**).
- **Endometrio ≥ 4-5 mm con sangrado en postmenopáusica**: BIOPSIA ENDOMETRIAL (Pipelle) OBLIGATORIA.
- **Factor de riesgo mayor de Cáncer de Endometrio**: Obesidad (aromatización periférica a estrógenos).
- **Cáncer de Ovario**: Neoplasia ginecológica más letal, se diagnostica tardíamente con síntomas digestivos vagos.
- **Criterios ecográficos IOTA de malignidad ovárica**: Proyecciones papilares sólidas > **3 mm**, septos gruesos, ascitis.



ENDOMETRIO ENGROSADO
Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 69

ALGORITMO · SANGRADO POSTMENOPÁUSICO Y MASA ANEXIAL

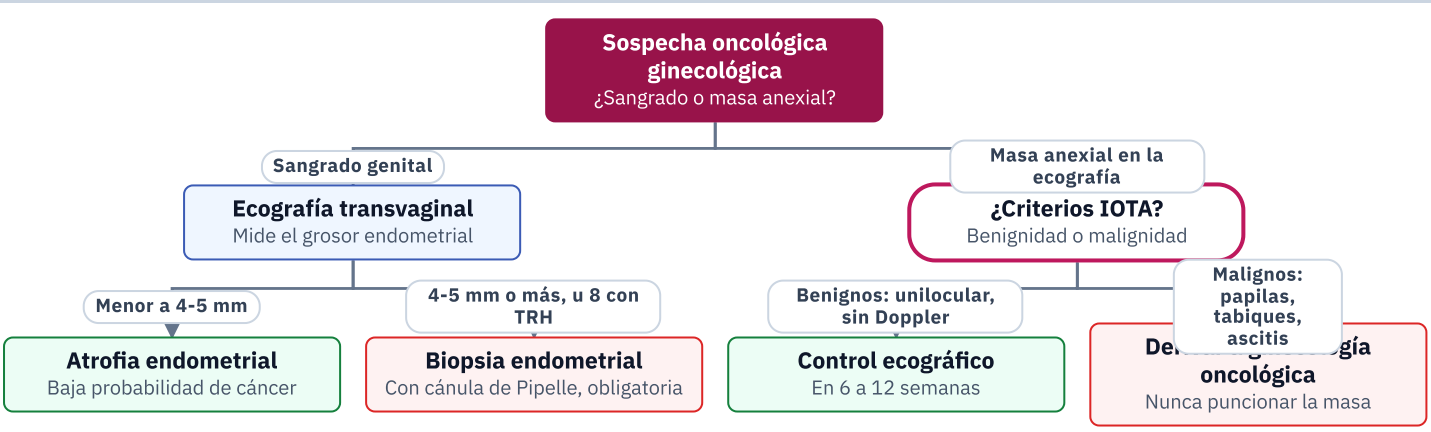


TABLA 20.15 · CRITERIOS ECOGRÁFICOS IOTA PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASAS OVÁRICAS

PARÁMETRO ECOGRÁFICO	CRITERIOS DE BENIGNIDAD (B-RULES)	CRITERIOS DE MALIGNIDAD (M-RULES)
Estructura de la Masa	Quiste unilocular puro (anecoico)	Tumor sólido irregular o multiloculado heterogéneo
Componente Sólido / Papilas	Ausencia de áreas sólidas o papilas < 3 mm	Presencia de proyecciones papilares ≥ 3 mm sólidas
Tabiques Internos	Sin tabiques o septos finos (< 3 mm)	Tabiques gruesos múltiples (> 3 mm)
Líquido Peritoneal	Sin líquido libre en cavidad	ASCITIS evidente perihepática y en Douglas
Vascularización Doppler	Sin flujo Doppler color (Score 1)	Flujo vascular Doppler central intenso (Score 4)
Sombra Acústica	Presencia de sombra acústica posterior (benigno)	Ausencia de sombra acústica con atenuación

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Sangrado postmenopáusico	Ecografía y biopsia si el endometrio ≥ 4-5 mm	Observar o dar hormonas sin biopsiar
Con terapia de reemplazo hormonal	El corte sube a 8 mm	Aplicar el mismo corte de 4-5 mm
Masa anexial con criterios IOTA benignos	Control ecográfico en 6 a 12 semanas	Cirugía o marcadores de entrada

REGLA DE ORO — **Sangrado postmenopáusico** — Es cáncer hasta que se descarte

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **73, 79–87** (págs. 18–20) · solucionario págs. 34–36.

Clase 20.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA & PATOLOGÍA MAMARIA

20.16 Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico

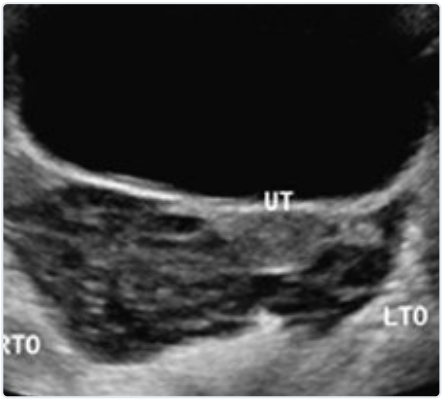
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
9 preguntas reales 2013–2025

3.01.2.019 Quiste ovárico torcido — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

También: Dolor pélvico agudo

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Torsión anexial**: Isquemia aguda del ovario y trompa por rotación sobre el pedículo infundíbulo-pélvico.
- **Tríada clásica de sospecha**: Dolor pélvico hiperagudo severo + Masa anexial palpable + Vómitos profusos (**80%**).
- **Factor predisponente principal**: Quiste ovárico de **5 a 10 cm** (especialmente Teratoma o quiste dermoide).
- La presencia de flujo arterial en el Doppler NO descarta la torsión ovárica (si hay sospecha clínica, se opera).
- **Tratamiento quirúrgico de elección en torsión**: LAPAROSCOPÍA URGENTE CON DETORSIÓN OVÁRICA CONSERVADORA.



OVARIO AUMENTADO
Nelson 22.ª ed., Fig. 590.4

ALGORITMO · DOLOR PÉLVICO AGUDO: TORSIÓN O QUISTE ROTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

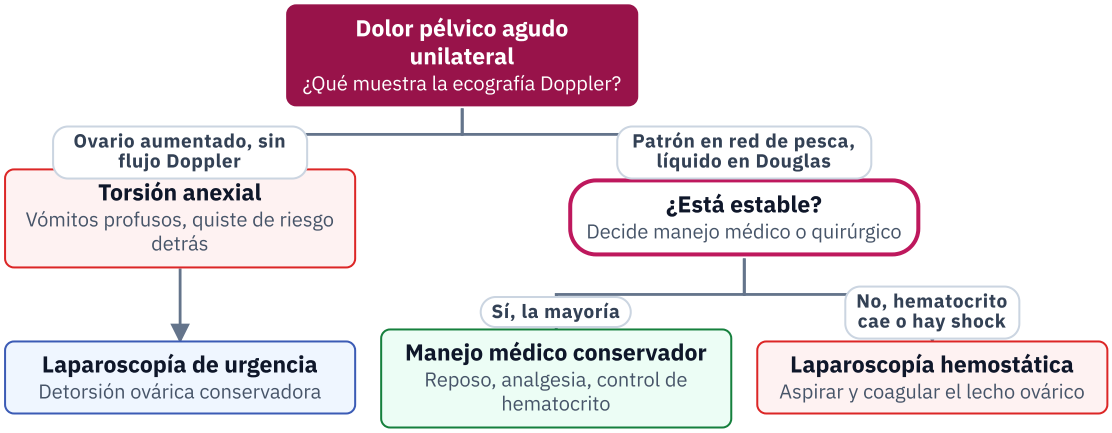


TABLA 20.16 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE TORSIÓN ANEXIAL Y QUISTE OVÁRICO HEMORRÁGICO ROTO

PARÁMETRO CLÍNICO	TORSIÓN ANEXIAL / OVÁRICA	QUISTE HEMORRÁGICO ROTO
Fisiopatología	Isquemia tisular aguda por rotación del pedículo vascular	Rotura de la cápsula ovárica con hemoperitoneo libre
Momento Típico del Ciclo	Cualquier momento del ciclo, embarazo o post-TRA	Fase lútea tardía (días 20-26 del ciclo menstrual)
Gatillante Frecuente	Movimientos bruscos o idiopático	Relaciones sexuales coitales recientes (postcoital)
Síntomas Acompañantes	Náuseas y vómitos profusos intensos (reflejo vagal)	Habitualmente sin vómitos; dolor pélvico que cede lentamente
Ecografía Doppler Color	Ovario muy aumentado, edematoso; flujo Doppler disminuido/ausente	Quiste con ecos reticulares en 'red de pesca' + líquido en Douglas
Conducta Inmediata	LAPAROSCOPÍA DE URGENCIA OBLIGATORIA	Manejo médico conservador expectante si estable
Técnica Quirúrgica	Detorsión ovárica conservadora (preservar ovario)	Laparoscopía hemostática solo si hay inestabilidad o hemoperitoneo masivo

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PARÁMETRO	TORSIÓN ANEXIAL	QUISTE HEMORRÁGICO ROTO
Vómitos	Profusos, en más de 80 de cada 100	Casi nunca
Ovario violáceo en cirugía	Se conserva igual	No aplica

REGLA DE ORO **Vómitos profusos + dolor hiperagudo** — Con un quiste de riesgo detrás

PRACTICA **Libro Gordo Ginecología**, preguntas **88–90** (pág. 20) · solucionario págs. 36–37.

Clase 20.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 16 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA, CICLO MENSTRUAL & SUA	
20.1 Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea	pág. 3
Cabergolina — **0,25 a 0,5 mg**, una o dos veces por semana	DOSIS
Pubertad precoz — Telarquia o pubarquia antes de los **8 años**	CORTE
Telarquia entre 8 y **13 años** — Primer signo: botón mamario, Tanner M2	CORTE
Primeros ciclos irregulares — Anovulatorios hasta **2-3 años** posmenarquia	CORTE
20.2 Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo	pág. 5
Criterio ecográfico actual: **≥ 20 folículos** de **2-9 mm** en al menos un ovario o volumen ovárico > **10 mL**.	DOSIS
20.3 Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo	pág. 6
Biopsia endometrial ambulatoria (Pipelle): OBLIGATORIA en toda mujer **≥ 45 años** con SUA.	CORTE
Menos de **5 %** a veinte años — Progestágenos y nueva biopsia a los **3-6 meses**	TIEMPO
Toda paciente postmenopáusica con sangrado uterino DEBE recibir biopsia de endometrio (corte ecográfico > **4 mm**).	CORTE
Hasta **25-40 %** tiene un cáncer concomitante — Histerectomía total si la paridad está cumplida	CORTE
BLOQUE 02 · ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN	
20.5 Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado	pág. 8
Multípara, **35 a 50 años** — No la joven nuligesta	CORTE
Cólico hipogástrico con la regla — Dura entre 8 y **72 horas**, irradia a la espalda y los muslos	TIEMPO
Edad Típica · Mujeres jóvenes en edad reproductiva (**20 a 35 años**) · Mujeres multíparas de **35 a 50 años**	CORTE
20.6 Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia	pág. 10
POP Estadio II: Descenso de órganos entre **-1 cm** y **+1 cm** del himen.	CORTE
POP-Q: Sistema de estadificación donde el plano de referencia himenal es el punto **0 cm**.	CORTE
20.7 Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida	pág. 11
Concentración normal **≥ 15 mill/mL**, motilidad progresiva **≥ 30-32%**.	DOSIS
35 años: adelanta a **6 meses** — No esperes los doce meses	TIEMPO
20.8 Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia	pág. 12
Vómito antes de **2 horas** — Repite la dosis completa	DOSIS
Fumadora de **35 años** o más — Quince cigarrillos al día o más	TIEMPO
Moco cervical y temperatura basal — Billings: claro y filante; la temperatura sube **0,3 a 0,5 °C**	CORTE
BLOQUE 03 · INFECCIONES GINECOLÓGICAS, PATOLOGÍA VULVAR & CLIMATERIO	
20.9 Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis	pág. 14
Tratamiento dual: Ceftriaxona **500 mg** IM + Doxiciclina **7 días**.	DOSIS
Tratamiento de Vaginosis: Metronidazol oral **500 mg** c/**12h** x **7 días**.	DOSIS
Candidiasis: Prurito intenso + leucorrea en 'leche cortada' adherente + pH ÁCIDO NORMAL (< 4.5).	CORTE
Vaginosis bacteriana: Criterios de Amsel (flujo blanco-grisáceo, pH > 4.5, aminas +, clue cells > **20%**).	CORTE
20.10 Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso	pág. 16
Riesgo de cáncer: **3 a 5%** — Cáncer epidermoide de vulva	CORTE
Tratamiento de elección en Liquen Escleroso: Propionato de Clobetasol al **0.05%** en ungüento tópico.	CORTE
20.11 Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos	pág. 17
Sin eso: esquema oral, **14 días** — Ceftriaxona, doxiciclina y metronidazol	TIEMPO
Cirugía de urgencia — Lavado y drenaje si hay rotura, shock o falla a las **48-72 h**	TIEMPO

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
20.12 Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos	pág. 18
¿Está en la ventana? — Menos de 60, o menos de **10 años**	CORTE
Diagnóstico de menopausia: Clínico (**12 meses** continuos de amenorrea en > **45 años**).	CORTE
Ventana de oportunidad de TRH: Iniciar en < **60 años** o < **10 años** postmenopausia para máximo beneficio y mínimo riesgo.	CORTE
BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA & PATOLOGÍA MAMARIA	
20.13 Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía	pág. 19
PAP cada **3 años** — De los 25 a los **64 años**	CORTE
PAP cada tres años — En mujeres de **25 a 64 años**	CORTE
Test de VPH — Desde los **30 años**, cada 5 si es negativo	CORTE
Preparación de la paciente — Fuera de la regla; **48 horas** sin relaciones, duchas ni óvulos	TIEMPO
20.14 Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna	pág. 21
Mamografía bienal — De los 50 a los **69 años**	CORTE
Firme, móvil, indoloro — En mujeres de **15 a 35 años**	CORTE
BI-RADS 3: Probablemente benigno (< **2%** riesgo); requiere seguimiento mamográfico en **6 meses**.	CORTE
El informe usa BI-RADS — 2 benigno, 3 control a **6 meses**, 4-5 biopsia	TIEMPO
20.15 Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores	pág. 23
Endometrio **≥ 4-5 mm** — U **8 mm** si usa terapia hormonal	CORTE
Sin flujo Doppler — Control ecográfico en **6 a 12 semanas**	TIEMPO
Histerectomía profiláctica — A los **40 años**, cumplida la paridad	CORTE
Papilas mayores a **3 mm** — Sólidas, proyectándose dentro del quiste	CORTE
20.16 Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico	pág. 24
Factor predisponente principal: Quiste ovárico de **5 a 10 cm** (especialmente Teratoma o quiste dermoide).	CORTE
Tríada clásica de sospecha: Dolor pélvico hiperagudo severo + Masa anexial palpable + Vómitos profusos (**80%**).	CORTE

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE	
20.2 Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo			pág. 5
Todo depende del deseo de embarazo · No desea embarazo	**Metformina si hay resistencia a la insulina**	Espironolactona si el hirsutismo persiste	
20.9 Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis			pág. 14
Los criterios de Amsel · Metronidazol	**Metronidazol oral**	Quinientos miligramos cada doce horas, siete días	
Prurito, y un pH que no cambia · Fluconazol	**Fluconazol en dosis única**	Ciento cincuenta miligramos vía oral	
Prurito, y un pH que no cambia · Fluconazol	**Clotrimazol vaginal, nunca fluconazol oral**		
La única de las tres que es ITS · Metronidazol, y a la pareja	**Metronidazol, dos gramos**	Una sola dosis por vía oral	
20.11 Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos			pág. 17
Pelviperitonitis · Hospitalizar y antibióticos	**Ayuno, hidratación y antibióticos EV**	Ceftriaxona + metronidazol + doxiciclina, o clindamicina + gentamicina	
20.14 Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna			pág. 21
El receptor decide el tratamiento · HER2 enriquecido	**Quimioterapia más trastuzumab**		
El receptor decide el tratamiento · Luminal B	**Combina quimioterapia y hormonoterapia**		
20.15 Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores			pág. 23
Cirugía etapificadora del endometrio · Adyuvancia	**Quimioterapia y radioterapia**		
Lynch y los tumores germinales · Tumores germinales	**Bleomicina, etopósido y cisplatino**		
Citorreducción, y nunca puncionar · Cirugía citorreductora	**Quimioterapia después**	Carboplatino más paclitaxel	

GES de Ginecología y Oncología

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES **GES Prevención y Entrega Gratuita Universal en Atención Primaria de Salud (Chile).**

Tema **20.8** · Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia
`3.01.3.008` · `3.01.3.006`
pág. **12**

GES **GES N° 3: Cáncer Cervicouterino (Tamizaje, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento garantizados).**

Tema **20.13** · Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía
`3.01.1.013` · `3.01.1.016` · `3.01.3.013`
pág. **19**

GES **GES N° 4: Cáncer de Mama en personas de 15 años y más (Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento).**

Tema **20.14** · Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna
`3.01.1.030` · `3.01.1.029` · `3.01.4.002`
pág. **21**

Fármacos de primera línea · continuación

Sin garantía GES específica (13 temas): 20.1 · 20.2 · 20.3 · 20.4 · 20.5 · 20.6 · 20.7 · 20.9 · 20.10 · 20.11 · 20.12 · 20.15 · 20.16. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

3 temas · ★★★

- ★★★ **20.3** Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo 6
- ★★★ **20.14** Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna 21
- ★★★ **20.13** Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía 19

Practica: Libro Gordo Ginecología, preguntas 11–16, 20, 62–72, 74–78.

DÍA 2

3 temas · ★★★

- ★★★ **20.15** Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores 23
- ★★★ **20.1** Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea 3
- ★★★ **20.9** Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis 14

Practica: Libro Gordo Ginecología, preguntas 3–7, 19, 45–54, 73, 79–87.

DÍA 3

3 temas · ★★★

- ★★★ **20.12** Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos 18
- ★★☆ **20.8** Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia 12
- ★★☆ **20.5** Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado 8

Practica: Libro Gordo Ginecología, preguntas 1, 21–29, 41–44, 60–61.

DÍA 4

3 temas · ★★

- ★★☆ **20.4** Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis 7
- ★★☆ **20.16** Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico 24
- ★☆☆ **20.7** Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida 11

Practica: Libro Gordo Ginecología, preguntas 17–18, 34–36, 88–90.

DÍA 5

2 temas · ★

- ★☆☆ **20.10** Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso 16
- ★☆☆ **20.2** Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo 5

Practica: Libro Gordo Ginecología, preguntas 8–10, 37–40.

DÍA 6

2 temas · ★

- ★☆☆ **20.11** Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos 17
- ★☆☆ **20.6** Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia 10

Practica: Libro Gordo Ginecología, preguntas 2, 30–33, 55–59.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 25
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 20.1 · 20.3 · 20.9 · 20.12 · 20.13 · 20.14 · 20.15
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Ginecología en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 7 temas

33 20.3. Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo 6
32 20.14. Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna GES 21
25 20.13. Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía GES 19
24 20.15. Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores 23
22 20.1. Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea 3
19 20.9. Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis 14
19 20.12. Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos 18

★★ Prioridad media · 4 temas

12 20.8. Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia GES 12
10 20.5. Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado 8
9 20.4. Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis 7
9 20.16. Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico 24

★ Prioridad baja · 5 temas

7 20.7. Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida 11
7 20.10. Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso 16
6 20.2. Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo 5
5 20.11. Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos 17
4 20.6. Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia 10